



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

RENCANA STRATEGI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

TAHUN 2026 - 2030

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0341 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

**LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
RS PRIMA HUSADA
TAHUN 2026- 2030**

Rencana Strategis (RENSTRA) RS Prima Husada sebagai bahan acuan target capaian program kerja Rumah Sakit Tahun 2026-2030

Disetujui,

Oleh

Direktur PT Disa Prima Medika



dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE

Rencana Strategi Rumah Sakit Prima Husada
Tahun 2026-2030

Disusun oleh :
Direktur RS Prima Husada Sukorejo



(Heni Indra Wulansari, S.Kep., Ns., M.Kep)

Disetujui oleh :
Authorized Person

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aslichah' with a stylized flourish at the end.

(Dr. dr. Aslichah, M.Kes, AFP)

Ditetapkan oleh :
Direktur PT Disa Prima Medika



(dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Yang Maha Kuasa atas rahmat serta hidayah-Nya sehingga Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo telah mampu menyusun Rencana Strategi untuk periode Tahun 2022-2026 dengan baik sesuai dengan target yang telah disusun bersama. Rencana Strategis Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2022-2026 ini, berisikan Visi, Misi, Faktor Kunci Keberhasilan, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Operasional yang secara langsung dilaksanakan oleh Rumah Sakit Prima Husada.

Dengan demikian diharapkan Rencana Strategis ini dapat digunakan oleh semua elemen masyarakat dan pemerintah sebagai pedoman dalam upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta dijadikan acuan dalam penyusunan program kerja tahunan.

Ditetapkan di Pasuruan,
Pada tanggal 24 Januari 2026
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Heni Indra Wulansari.,S.Kep.,Ns., M.Kep

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI..... v

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO..... 1

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2026-2030 3

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN..... 6

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi..... 6

2.2 Sumber Daya Kesehatan..... 8

2.2.1. Tenaga..... 8

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kesehatan 14

2.2.3. Anggaran 15

2.3 Kinerja Pelayanan 15

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 20

2.4.1. Kekuatan..... 20

2.4.2. Kelemahan..... 21

2.4.3 Peluang..... 21

2.4.4 Ancaman..... 21

2.5 Potensi dan Permasalahan..... 22

2.5.1. Geografis 22

2.5.2. Pelayanan 22

2.5.3. Alat Kedokteran dan Kesehatan yang tersedia 22

2.5.4. Pembiayaan 22

2.5.5. Kondisi Sosial Budaya 23

2.5.6. Pesaing Rumah Sakit..... 23

2.5.7. Pemasaran..... 23

BAB III ISU-ISU STRATEGIS 25

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan 25

3.2. Telaah Renstra Kementerian RI /Lembaga (K/L) 26

3.3. Penentuan Isu – Isu Strategis 26

BAB IV VISI, MISI, LANDASAN NILAI, DAN TUJUAN 26

6.1. Visi 28

6.2. Misi..... 28

6.3. Falsafah..... 28

6.4. Landasan Nilai..... 28

6.5. Tujuan 28

6.6. Motto 28

BAB V POSISI BISNIS..... 29

5.1. Swot Analisis	29
5.1.1 KEKUATAN	30
5.1.2 KELEMAHAN	30
5.1.3 PELUANG	31
5.1.4 ANCAMAN.....	33
5.2 Hasil Analisa.....	34
5.2.1 Analisa Internal	34
5.2.2 Analisa Eksternal	34
BAB VI KEBIJAKAN DAN STRATEGI	36
6.1 Kebijakan.....	36
6.2. Strategi	36
BAB VII RENCANA BISNIS STRATEGIS (RBS) DAN TARGET RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO TAHUN 2026-2030	39
BAB VIII PROYEKSI KEUANGAN RS PRIMA HUSADA SUKOREJO TAHUN 2026 sd 2030.....	46
8.1 Data Pendapatan 2025 (<i>angka dalam juta Rupiah</i>)	46
8.2 Data Biaya 2025 (<i>angka dalam juta Rupiah</i>).....	Error! Bookmark not defined.
8.3 PROYEKSI	47
Tabel 8.3.1 Rincian Pendapatan (<i>angka dalam juta Rupiah</i>)	47
Tabel 8.3.2. Pendapatan dan Biaya (<i>angka dalam juta Rupiah</i>)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 8.3.3. Proyeksi Pendapatan Perunit Tahun 2026 sd 2030	Error! Bookmark not defined.
BAB IX PENUTUP.....	48
LAMPIRAN	

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 041.1/RSPHS/I-PER/DIR/II/2026**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2026 – 2030

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : bahwa guna meningkatkan sistem perencanaan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo maka Rencana Strategis Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Tahun 2026 – 2030 ;
- Mengingat :
 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan;
 2. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 3. Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan yang mengatur tata kelola secara lebih komprehensif;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2025 -2029;
 7. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
 8. Keputusan Direktur RS Prima Husada Nomor : 935.4/RSPHS/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : KEPUTUSAN DIREKTUR RS PRIMA HUSADA TENTANG RENCANA STRATEGIS TAHUN 2026 – 2030.
- Kedua : Rencana Strategis Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2026 – 2030 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Strategis digunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh Instalasi di Rumah Sakit Prima Husada dalam kurun waktu 5 tahun mendatang

-
- Keempat : Rencana Strategis ini dapat berubah sewaktu-waktu jika memang terjadi perubahan target, strategi, visi, misi, motto, nilai dan hal khusus yang dirasa perlu.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan,
Pada tanggal 24 Januari 2026
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Heni Indra Wulansari.,S.Kep.,Ns., M.Kep

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR: 041.1/RSPHS/I-PER/DIR/II/2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, menetapkan Sistem Kesehatan Nasional sebagai paradigma pemikiran dasar pengelolaan administrasi pembangunan kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya dapat terwujud. Hal ini dilaksanakan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil, dan merata, dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin. Untuk mewujudkannya perlu disusun suatu Rencana Strategis (Renstra).

Menyadari pentingnya rencana strategis suatu organisasi, khususnya lembaga swasta yang memberikan pelayanan kepada publik, maka semua pihak dalam suatu organisasi harus membangun pemahaman bersama-sama dalam mengembangkan arah (*sense of direction*) untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pengembangan visi, misi, maksud (*goal*) dan tujuan (*objective*) yang akan dicapai merupakan konsensus bersama.

Rumah sakit Prima Husada sebagai salah satu jenis RS swasta merupakan bagian dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Sebagai RS swasta harus mengedepankan mutu yang searah dengan efisiensi dan efektifitas sebagai bagian dari kendali biaya dan kendali mutu yang harus terus menerus diterapkan dalam pengelolaan RS swasta.

Perkembangan pengelolaan rumah sakit, baik dari aspek manajemen maupun operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, yaitu antara lain bahwa rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien. Tuntutan lainnya adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak yaitu mekanisme pasar, tindakan ekonomis, SDM apalagi dengan adanya akreditasi sebagai RS yang terstandard, yang profesional dan yang tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi dari rumah sakit itu sendiri.

Latar belakang penyusunan rencana strategi RS Prima Husada Sukorejo tahun 2026 didasari oleh kebutuhan untuk mewujudkan visi menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan masyarakat melalui pelayanan yang aman, tepat, dan akurat. Secara internal, rumah sakit menghadapi tantangan operasional seperti tingkat *turnover* karyawan yang mencapai 9,3% pada tahun 2025 dan perlunya transformasi budaya organisasi untuk meningkatkan kepuasan pasien. Evaluasi kinerja tahun sebelumnya menunjukkan adanya tren penurunan kunjungan di beberapa unit, sehingga diperlukan strategi baru untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan penguatan nilai-nilai inti perusahaan.

Dari sisi eksternal, rumah sakit dihadapkan pada perubahan regulasi kesehatan yang signifikan di Indonesia, termasuk pemberlakuan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan transisi sistem klaim dari INACBGs ke IDRG. Ketergantungan yang tinggi pada pasien BPJS Kesehatan yang mencakup lebih dari 77% pendapatan menuntut rumah sakit untuk lebih adaptif terhadap kebijakan rujukan berbasis kompetensi. Selain itu, persaingan dengan rumah sakit kompetitor di wilayah Pasuruan semakin ketat, sehingga RS Prima Husada harus memperkuat posisi tawarnya melalui keunggulan kompetitif dan digitalisasi layanan.

Fokus utamanya mencakup perluasan pangsa pasar melalui layanan unggulan, peningkatan efisiensi operasional berbasis teknologi informasi, serta pengembangan kompetensi SDM. Dengan melakukan analisis SWOT yang mendalam, rumah sakit berupaya memanfaatkan kekuatan akreditasi Paripurna dan dukungan pemilik untuk menangkap peluang kerja sama asuransi serta meningkatkan retensi pasien melalui pengalaman pelayanan yang lebih personal dan profesional.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Rumah Sakit Prima Husada 2026–2030 disusun berdasarkan:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian yang mengatur tata kelola secara lebih komprehensif;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2025 -2029;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana strategis disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran rencana jangka panjang pengembangan Rumah Sakit Prima Husada selama 5 tahun kedepan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan. Dalam penyusunan Renstra tersebut juga dimaksudkan untuk menselaraskan antara **perencanaan tahunan, pelaksanaan program** serta pencapaian indikator lima (5) tahun kedepan secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan rencana strategis tersebut adalah sebagai pedoman atau acuan bagi manajemen maupun satuan kerja di Rumah Sakit Prima Husada dalam penyusunan anggaran maupun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2026 – 2030 sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada Latar Belakang mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Strategis Rumah Sakit Prima Husada, fungsi Rencana Strategis dalam penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit, dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, juga termuat landasan hukum serta maksud dan tujuan serta sistematika penulisan rencana startegis.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN RUMAH SAKIT

Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Rumah Sakit Prima Husada dalam penyelenggaraan pelayanan, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit Prima Husada dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS

Membahas terkait tentang :

1. Kelas rawat inap standart
2. Rumah Sakit berbasis kompetensi
3. Perubahan INA-CBGs menjadi IDRG
4. Transformasi digital dan sistem informasi
5. Layanan berorientasi pada kepuasan pelanggan
6. Kualitas SDM
7. Produktivitas dan efisiensi operasional rumah sakit
8. Ketergantungan pada BPJS Kesehatan

BAB 4 VISI, MISI, LANDASAN NILAI DAN TUJUAN

Pada bagian ini memuat Visi, Misi, Landasan Nilai dan Tujuan Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2026 - 2030

BAB 5 POSISI BISNIS

Pada bagian ini dikemukakan tentang SWOT Analysis.

BAB 6 KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pada bagian ini dikemukakan tentang Kebijakan dan Strategi untuk pencapaian Rencana strategis.

BAB 7 RENCANA PROGRAM PENCAPAIAN SASARAN RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

Pada bagian ini dikemukakan tentang program pencapaian strategi dan sasaran meliputi kebijakan, program, kegiatan dan *action plan MELALUI Balance Score Card*.

BAB 8 PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

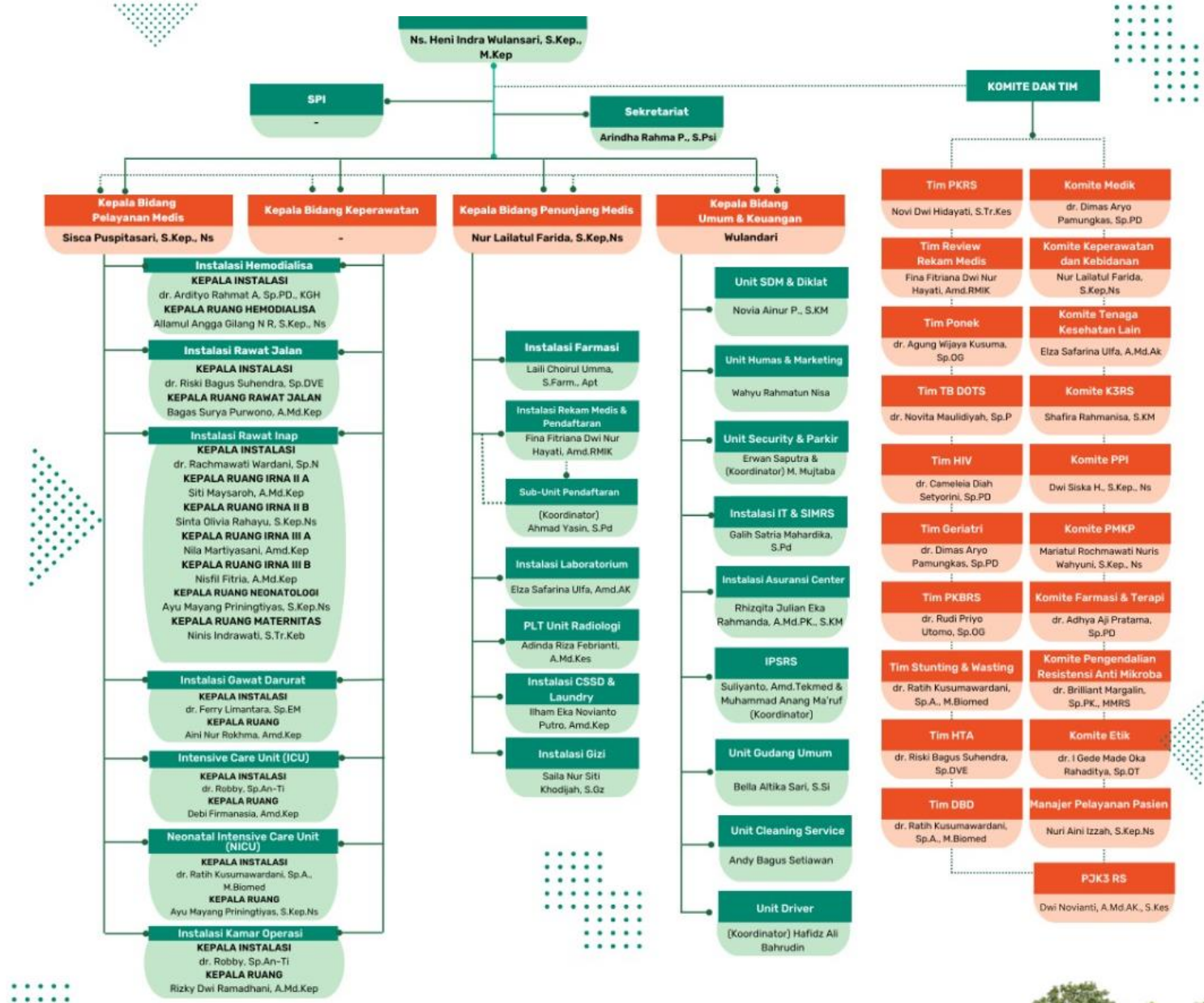
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Rumah Sakit Prima Husada mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan dari Pelayanan Kesehatan Tingkat I, pengembangan iptek di bidang kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, rumah sakit mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan Pelayanan Medik
2. Penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan
3. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik
4. Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi
5. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO TAHUN 2026



2.2 Sumber Daya Kesehatan
2.2.1. Tenaga

Potensi SDM yang dimiliki Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo saat ini cukup memadai,. Saat ini Rumah Sakit Prima Husada merupakan rumah sakit Tipe C. Untuk meningkatkan produktifitas karyawan, senantiasa diupayakan peningkatan kesejahteraan pegawai, pengembangan kompetensi melalui pendidikan, kursus dan pelatihan yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit.

Pemberian pelayanan pada pengguna jasa Rumah Sakit Prima Husada saat ini didukung oleh 532 tenaga, yang terdiri atas 68 tenaga medis meliputi dokter umum dan dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis, 191 tenaga perawat, 23 bidan, 51 tenaga farmasi, 43 tenaga kesehatan lainnya dan 156 tenaga non kesehatan. Di masa mendatang dibutuhkan tambahan beberapa tenaga, antara lain: dokter ruangan, dokter klinik perusahaan perawat hiperkes, bidan, ATEM, radiografer, TTK dan IT.

No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
1	Direktur	S2 Kesehatan	1	1	0	0	1	0	0	1
2	Kepala Bidang Pelayanan Medis	S1 Kesehatan	1	1	0	0	1	0	0	1
3	Kepala Bidang Keperawatan	Profesi Ners	1	0	0	0	0	0	0	0
4	Kepala Bidang Penunjang Medis	S1 Kesehatan	1	1	0	0	1	0	0	1
5	Kepala Bidang Umum & Keuangan	SMA/S1	1	1	0	0	1	0	0	1
6	Staf Medis	Dokter Umum IGD	9	9	0	9	0	0	0	
		Dokter Case Mix	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Ruangan	1	0	1	0	0	0	0	
		Dokter Umum Klinik Perusahaan	5	5	0	5	0	0	0	
		Dokter Gigi	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Emergency	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesiais Obgyn	3	3	0	3	0	0	0	
		Dokter Spesialis Anak	4	4	0	4	0	0	0	
		Dokter Spesialis Penyakit Dalam	5	5	0	5	0	0	0	
		Dokter	1	1	0	1	0	0	0	

No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
		Spesialis Penyakit Dalam Subspesialis Ginjal-Hipertensi								68
		Dokter Spesialis Bedah	3	3	0	3	0	0	0	
		Dokter Spesialis Bedah Anak	1	0	1	0	0	0	0	
		Dokter Spesialis Bedah Syaraf	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Bedah Plastik	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi	3	3	0	3	0	0	0	
		Dokter Spesialis Neurologi	4	4	0	4	0	0	0	
		Dokter Spesialis Paru	3	3	0	3	0	0	0	
		Dokter Spesialis Mata	3	3	0	3	0	0	0	
		Dokter Spesialis Kulit Kelamin	2	1	1	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Jantung & Pembuluh Darah	3	3	0	3	0	0	0	
		Dokter Spesialis THT	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Urologi	2	1	1	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Konservasi Gigi	1	0	1	0	0	0	0	
		Dokter Spesialis Gigi Anak	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Patologi	1	1	0	1	0	0	0	

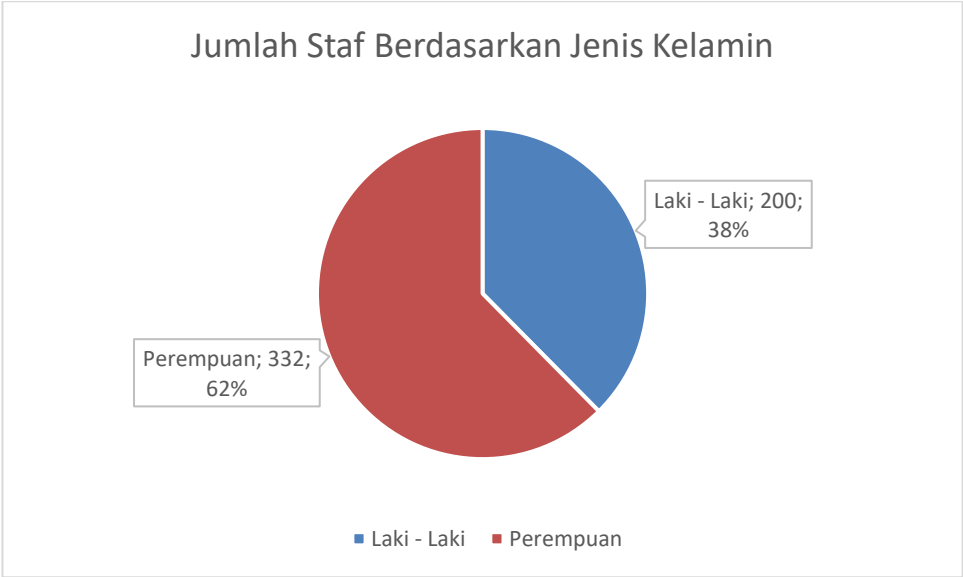
No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
		Anatomi								
		Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Radiologi	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Anastesiologi	5	5	0	4	1	0	0	
7	IRNA II A	D3 Keperawatan	26	14	0	6	8	0	0	25
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		12	1	10	2	0	0	
8	IRNA II B	D3 Keperawatan	25	7	0	2	5	0	0	24
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		18	1	14	4	0	0	
9	IRNA III A	D3 Keperawatan	20	10	0	3	7	0	0	20
		D4 Keperawatan		1	0	0	1	0	0	
		Profesi Ners		9	0	5	4	0	0	
10	IRNA III B	D3 Keperawatan	20	11	2	5	6	0	0	18
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		7	2	6	1	0	0	
11	Neonatologi	D3 Keperawatan	4	1	0	1	0	0	0	1
		S1 Kebidanan		0	0	0	0	0	0	
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		0	3	0	0	0	0	
12	Maternitas	D3 Kebidanan	14	3	0	0	3	0	0	13
		D4 Kebidanan		9	0	2	7	0	0	
		S1 Kebidanan		1	1	0	1	0	0	
13	ICU	D3 Keperawatan	11	4	0	3	1	0	0	10
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		7	1	7	0	0	0	
14	NICU	D3 Keperawatan	9	5	0	1	4	0	0	9
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		4	0	0	4	0	0	
15	IGD	D3 Keperawatan	28	7	0	3	4	0	0	26
		D3 Kebidanan		3	0	1	2	0	0	

No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		D4 Kebidanan		2	0	1	1	0	0	
		Profesi Ners		15	5	12	3	0	0	
		S1 Kebidanan		0	1	0	0	0	0	
16	IKO	D3 Keperawatan	13	10	0	6	4	0	0	13
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		3	0	1	2	0	0	
17	IRJA	D3 Keperawatan	26	14	0	2	12	0	0	25
		D3 Perawat Gigi		1	0	1	0	0	0	
		D3 Kebidanan		1	0	0	1	0	0	
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		D4 Kebidanan		1	0	0	1	0	0	
		S1 Kebidanan		1	0	0	1	0	0	
		Profesi Ners		7	1	4	3	0	0	
18	Klinik ATOM	D3 Keperawatan	2	2	1	1	1	0	0	1
19	Klinik Nestle	S1 Profesi Keperawatan	1	1	0	1	0	0	0	1
20	Klinik Lyondelbasel	Profesi Ners	1	1	0	1	0	0	0	1
21	Klinik KT&G Purwosari	D3 Keperawatan	2	2	0	2	0	0	0	2
22	Klinik KT&G Singosari	D3 Keperawatan	1	1	0	1	0	0	0	1
		Psikologis Klinik	1	1	0	1	0	0	0	1
23	Orientasi Perawat	Profesi Keperawatan	20	16	4	16	0	0	0	16
		S1 Profesi Kebidanan	1	0	1	0	0	0	0	
24	Rehab Medik	D3 Fisioterapi	5	1	0	1	0	0	0	5
		D4/S1 Fisioterapi		4	0	4	0	0	0	
25	Farmasi	SMA/ SMK Farmasi	3	3	0	2	1	0	0	51
		S1 Admin Farmasi / S1 Lainnya	1	1	0	0	1	0	0	
		D3 Farmasi	30	30	0	25	5	0	0	
		D3 Analisis Farmasi	1	1	0	1	0	0	0	
		S1 Farmasi	4	4	0	3	1	0	0	
		Apoteker	12	12	0	5	7	0	0	
26	Rekam Medis	D3 RMIK	8	7	0	5	2	0	0	8
		D4 RMIK		1	0	0	1	0	0	

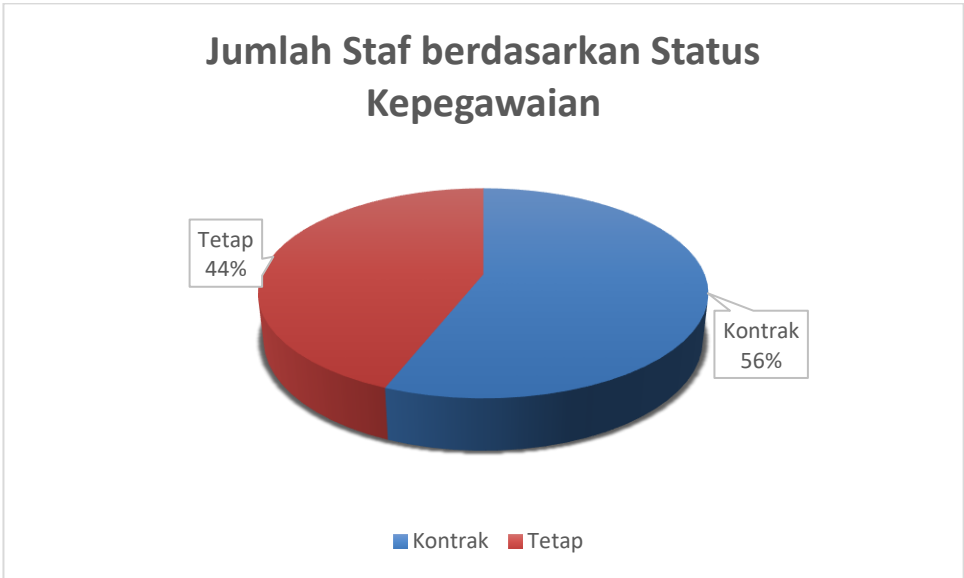
No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
27	Pendaftaran	SMA/SMK	19	2	0	0	2	0	0	18
		D1		1	0	1	0	0	0	
		D3		5	0	1	4	0	0	
		D4		2	0	1	1	0	0	
		S1		8	1	8	0	0	0	
28	Laboratorium	D3 Analis Kesehatan	12	9	0	2	7	0	0	12
		D4 Analis Kesehatan		3	0	2	1	0	0	
29	Radiologi	SMA/SMK	8	0	0	0	0	0	0	7
		D3 Radiologi		7	1	6	1	0	0	
30	CSSD	SMA/SMK	4	3	0	1	2	0	0	4
		D3 Keperawatan		1	0	0	1	0	0	
		S1 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
31	Laundry	SMA/SMK	6	5	0	2	3	0	0	6
		D1		1	0	1	0	0	0	
32	Ahli Gizi	D3 Gizi	6	3	0	3	0	0	0	6
		D4 Gizi		3	0	0	2	0	0	
		S1 Gizi		1	0	0	1	0	0	
33	Dapur Penyaji & Pantry	SMA/SMK	15	15	0	6	9	0	0	15
34	Keuangan & Akuntansi	SMA/SMK	9	0	0	0	0	0	0	9
		D1		1	0	0	1	0	0	
		D3		0	0	0	0	0	0	
		S1		8	0	1	7	0	0	
35	SDM & Diklat	S1 Psikologi	2	1	0	1	0	0	0	2
		S1 Manajemen		0	0	0	0	0	0	
		S1 Kesehatan		1	0	0	1	0	0	
		S1 Lainnya		0	0	0	0	0	0	
36	Asuransi Center	SMA/SMK	13	1	0	1	0	0	0	12
		D3 RMIK		4	0	4	0	0	0	
		D3 Asuransi Kesehatan		4	0	1	3	0	0	
		D4 RMIK		1	0	0	1	0	0	
		D4 Asuransi Kesehatn		0	0	0	0	0	0	
		S1 Kesehatan / Lainnya		3	0	0	3	0	0	
37	Humas Marketing	S1 Marketing	2	0	0	0	0	0	0	2
		D3 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		S1 Profesi Keperawatan		1	0	1	0	0	0	

No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
		SMA / SMK		1	0	0	1	0	0	
38	Sekretariat	S1	1	1	0	0	1	0	0	1
39	Security	SMA/SMK	12	11	1	0	11	0	0	11
40	Parkir	SMA/SMK	12	12	0	12	0	0	0	12
		S1 Lainnya		1	0	1	0	0	0	
41	Driver	SMA/SMK	7	7	0	0	7	0	0	7
42	Cleaning Service	SMA/SMK	42	42	0	14	28	0	0	42
		D3		1	0	0	1	0	0	
43	CS Outdoor	SMA/SMK	3	3	0	3	0	0	0	3
44	IPSRs	SMA/SMK	4	4	0	3	1	0	0	5
		D3 ATEM	2	1	1	1	0	0	0	
45	Gudang Umum	S1	1	1	0	0	1	0	0	1
46	IT & SIMRS	D4 Teknologi Informasi	3	0	0	0	0	0	0	2
		S1 Teknologi Informatika		2	1	2	0	0	0	
		S1 Lainnya		1	0	0	1	0	0	
47	PKRS	DIV Promosi Kesehatan	1	1	1	1	0	0	0	1
48	Mutu	S1 Kesehatan Masyarakat	1	1	0	1	0	0	0	1
49	PPI	S1 Keperawatan	1	1	0	0	1	0	0	1
50	K3RS	S1 Kesehatan Masyarakat	1	0	0	0	1	0	0	1
51	MOD/PIPP	D3 Keperawatan	5	2	0	0	2	0	0	5
		D3 Kebidanan		1	0	0	1	0	0	
		D4 Kebidanan		1	0	0	1	0	0	
		Profesi Ners		1	1	0	1	0	0	
		S1 Kebidanan		0	0	0	0	0	0	
TOTAL			560	532	329	298	234	0	0	532

Data Jumlah tenaga Yang ada di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Tahun 2025 berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui Sebagian besar tenaga kerja di RS Prima Husada Sukorejo adalah berjenis kelamin perempuan sejumlah 332 orang dengan presentasi 62% sedangkan karyawan dengan jenis kelamin laki – laki sejumlah 200 orang dengan presentase 38% dari total keseluruhan staf 532 orang.



Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 298 karyawan dengan status kepegawaian kontrak atau dengan presentasi 56% sedangkan untuk status kepegawaian karyawan tetap sejumlah 234 orang atau 44% dari total keseluruhan staf 532 orang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo telah mengembangkan pelayanan dengan 24 spesialis yang berpraktek di Instalasi Rawat Jalan (IRJA). RSPH Jadwal praktek dokter spesialis sesuai jadwal terlampir. Untuk pelayanan rawat Inap (IRNA), dilengkapi dengan 9 dokter penunjang yaitu 5 dokter spesialis anastesi, 2 dokter radiologi, 1 dokter patologi klinik dan 1 dokter spesialis patologi anatomi. **(terlampir pada lampiran 1)**

Jumlah Tempat tidur yang telah diatur oleh Direktur RSPH Sukorejo Nomor : 115 /RSPHS/I-PER/DIR/I/2025 sebanyak 180 TT dengan rincian tempat tidur untuk pelayanan asuhan pasien sebagai berikut :

NO	JENIS KELAS	JUMLAH	GRAND TOTAL	
VIP				
1	Rawat Inap Reguler	9	5,6%	
2	Rawat Inap Maternitas	1		
KELAS 1				
3	Rawat Inap Reguler	40	25,0%	
4	Rawat Inap Maternitas	5		
KELAS 2				
5	Rawat Inap Reguler	12	7,8%	
6	Rawat Inap Maternitas	2		
KELAS 3				
7	Rawat Inap Reguler	69	40,6%	
8	Rawat Inap Maternitas	4		
INTENSIVE CARE			10,6%	
9	ICU dengan Ventilator	8		6,1%
	ICU tanpa ventilator	2		
	ICU Isolasi Tekanan Negatif	1		
INTENSIVE LAINNYA				4,4%
10	NICU dengan ventilator	1		
	NICU tanpa ventilator	7		
ISOLASI				
11	Isolasi Tekanan Negatif	8		10,6%
	Isolasi Anak	4		
	Isolasi Dewasa	7		
TOTAL		180	100%	

Sebagai Rumah Sakit tipe C Rumah Sakit Prima Husada ditunjang oleh sarana penunjang klinik dan non klinik.

Sarana penunjang terdiri dari Instalasi Farmasi, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Rekam Medis, Instalasi Gizi, Instalasi CSSD & Laundry

Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRs) didukung dengan sebuah unit genset dengan kapasitas 1000 KVA yang saat ini sudah menjamin ketersediaan pasokan listrik pada saat listrik dari PLN padam.

2.2.3. Anggaran

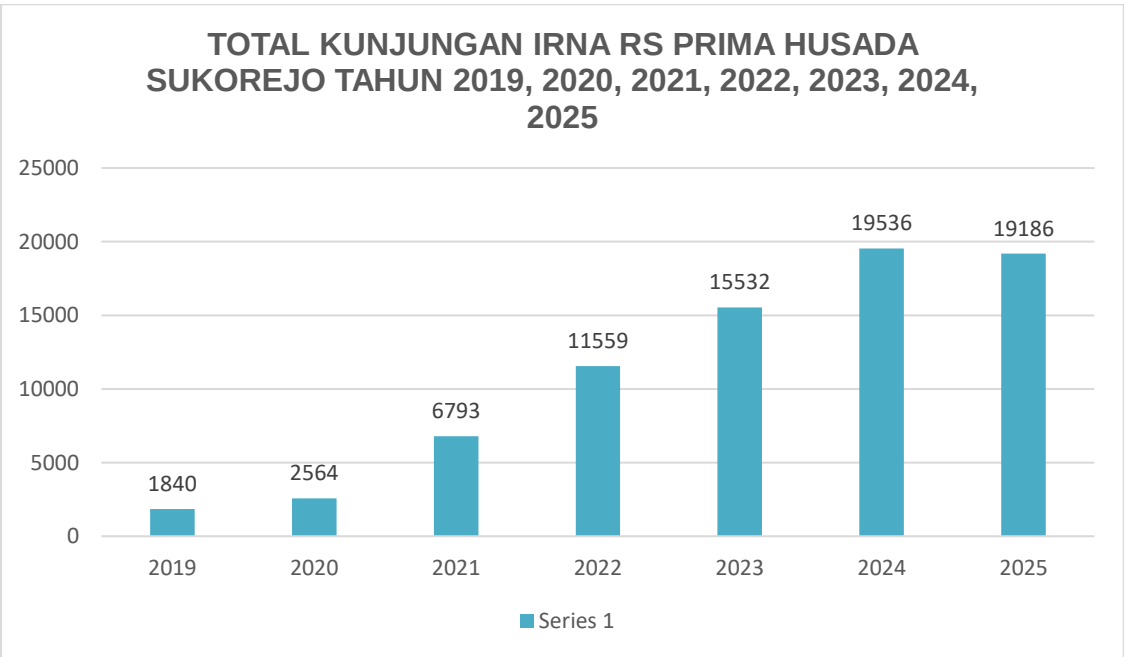
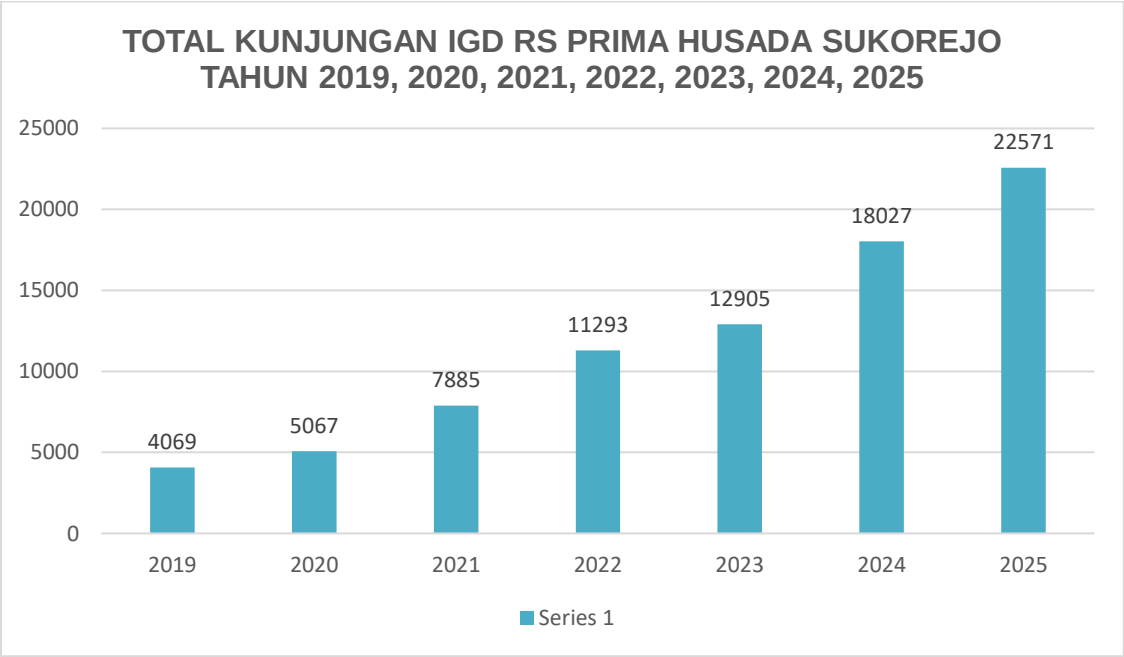
Anggaran yang disediakan pemilik untuk Rumah Sakit Prima Husada selama 1 tahun terakhir mengalami peningkatan. Anggaran setiap tahun yang disetujui oleh pemilik yang tertera dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dikelola oleh pemilik yaitu PT.DPM yang sekaligus sebagai pengendali anggaran. Semua kegiatan dan kebutuhan peralatan untuk pengembangan RS disentralkan di PT.DPM sebagai pejabat pembuat komitmen yang menentukan persetujuan pengadaan barang dan pembeliannya. .

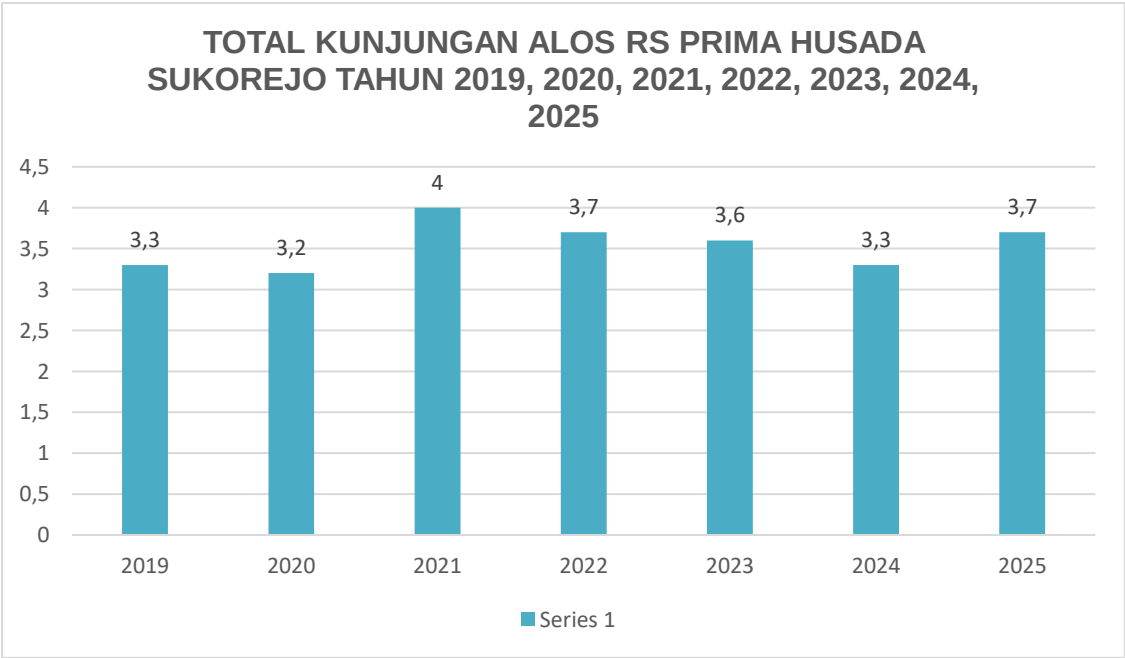
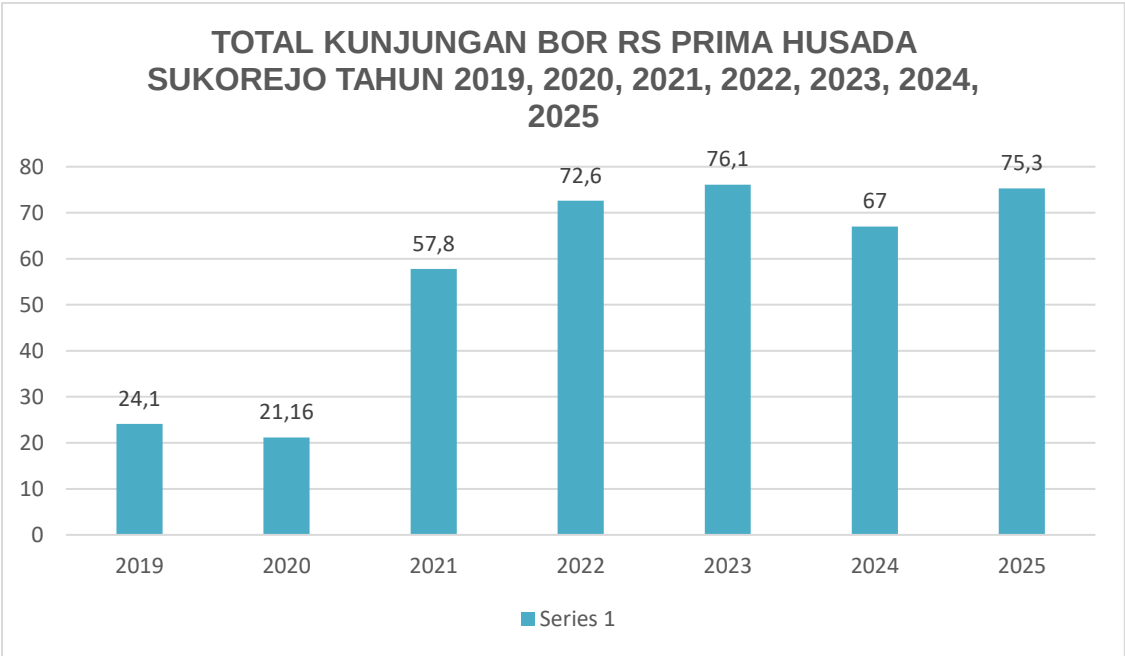
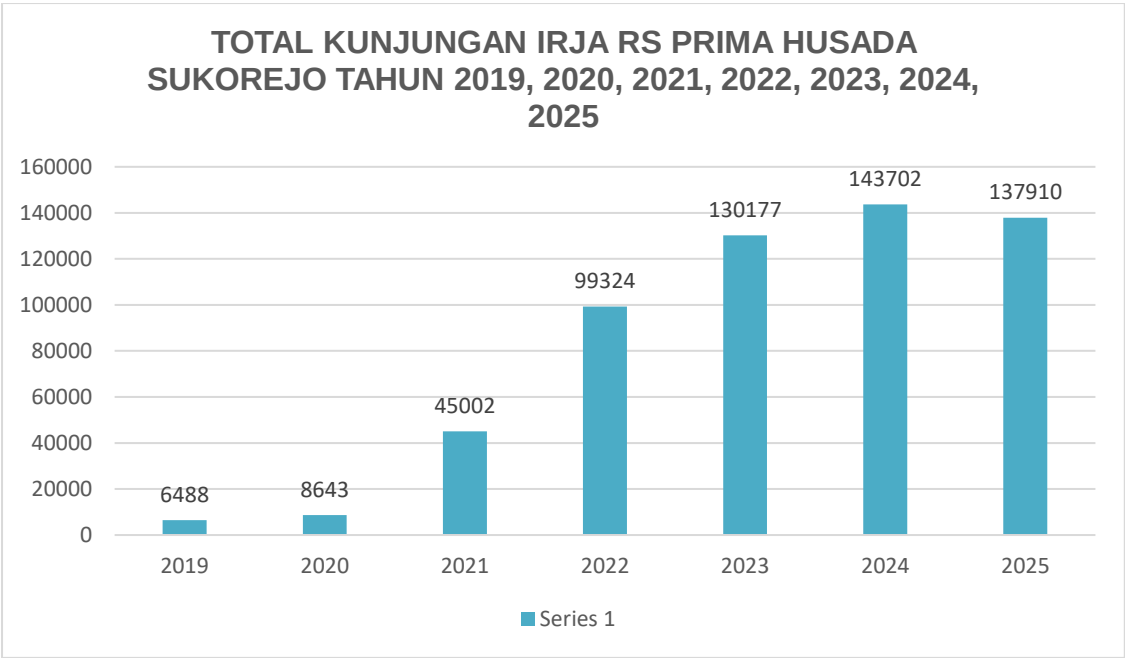
2.3 Kinerja Pelayanan

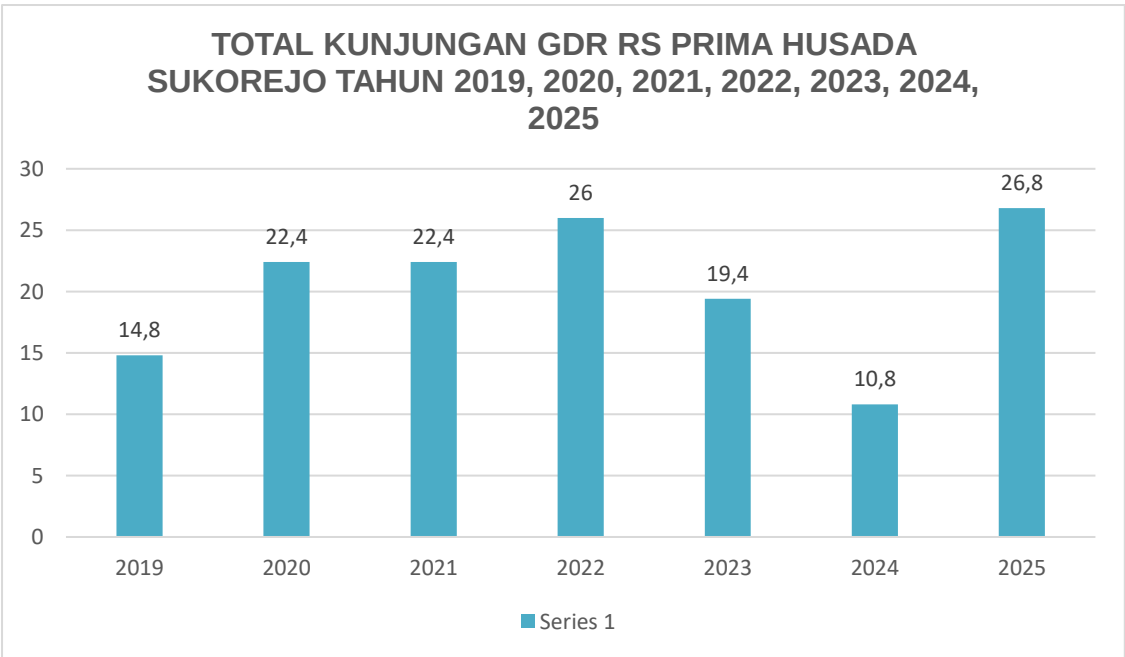
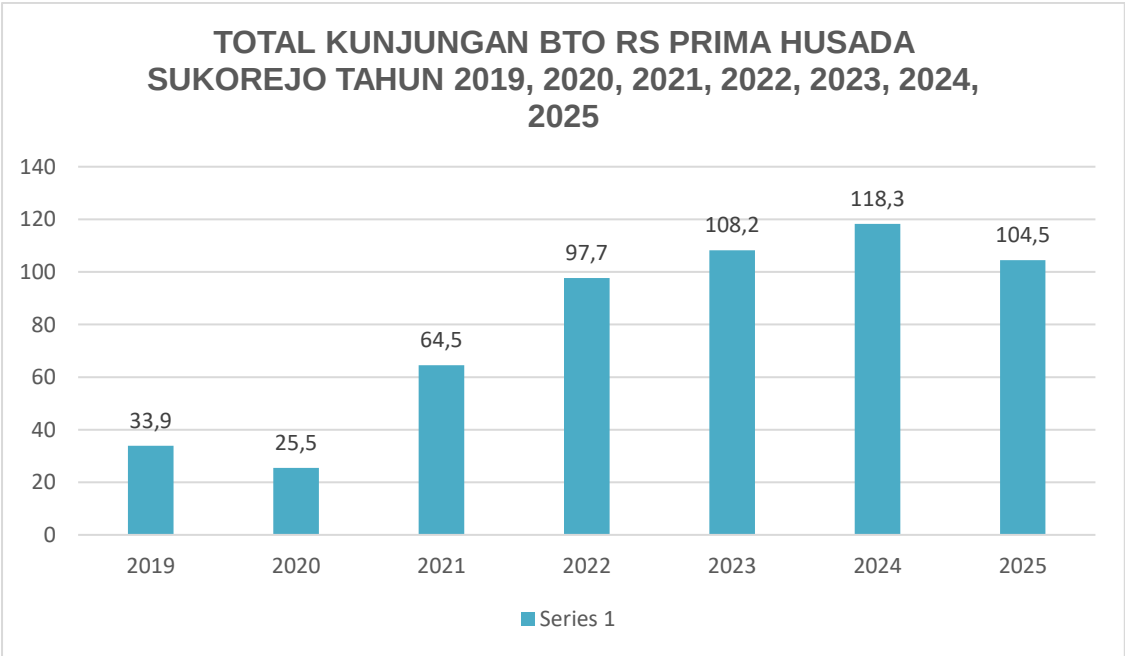
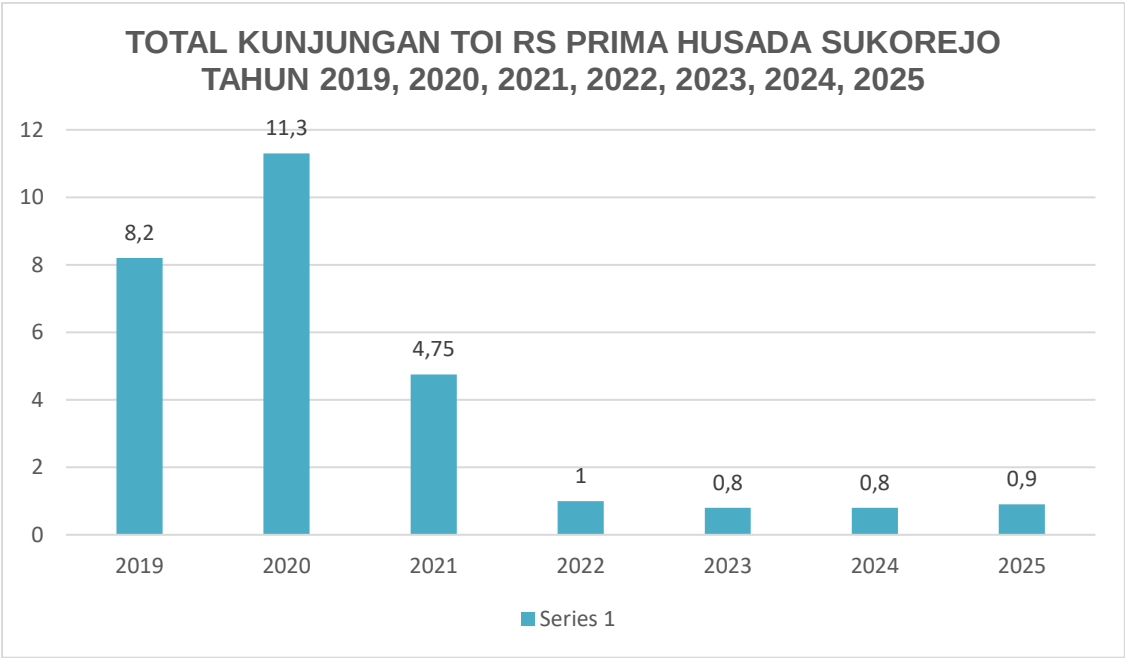
Indikator kinerja RSPH tingkat efisiensi penggunaan dan pengelolaan ruangan sejak tahun 2019-2025 banyak perubahan yakni

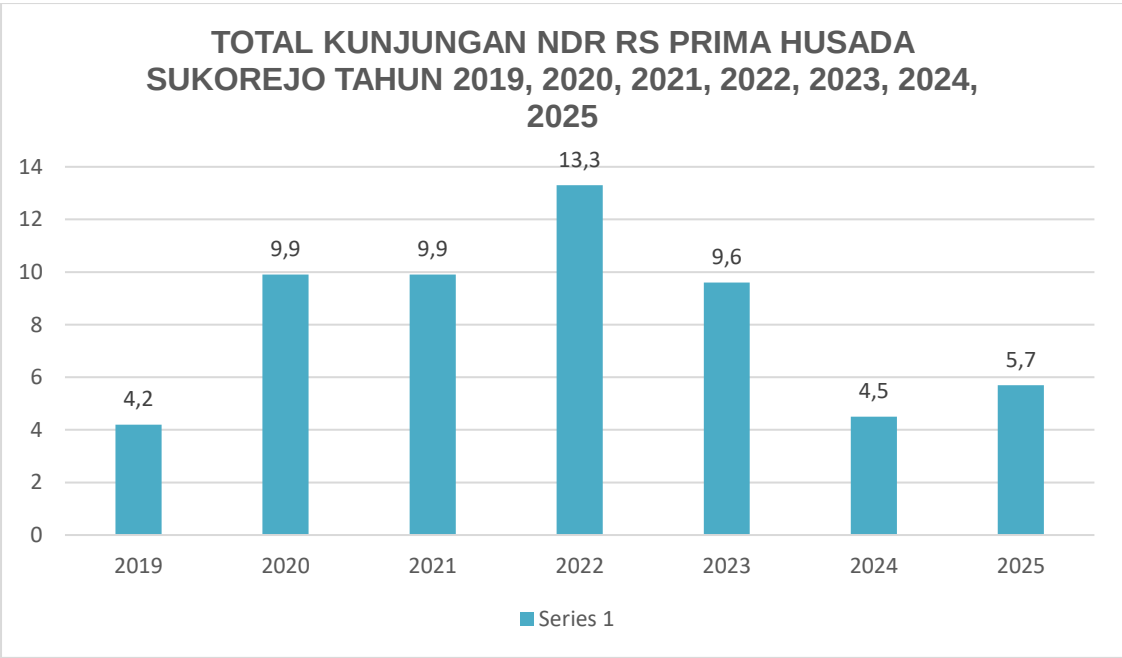
- a. Pencapaian kunjungan IGD pada tahun 2019 awal operasional cukup baik sebesar 2687 pasien sedangkan tahun 2020 menurun menjadi 1200 dan pada tahun 2021 sd bulan nopember meningkat menjadi 2883 kunjungan.
- b. Pencapaian kunjungan Rawat Inap mulai tahun 2019 sampai 2025 mengalami peningkatan. Capaian kunjungan tahun 2019 mencapai 1840, tahun 2020 mencapai 2564, tahun 2021 mencapai 6793, tahun 2022 mencapai 11559, tahun 2023 mencapai 15532, tahun 2024 mencapai 19536 dan tahun 2025 mencapai 19186. Kunjunga pasien rawat inap terjadi Capaian BOR tahun 2025 75,8 %
- c. Pencapaian kunjungan Rawat jalan berturut-turut terjadi kenaikan dan pada Tahun 2019 (1840), tahun 2020 (2564), tahun 2021 (45002), tahun 2022 (99324), tahun 2023 (130177), tahun 2024 (143702) dan menjadi 137910 di tahun 2025. Terjadi penurunan jumlah kunjungan di tahun 2025 karena adanya kebijakan eksternal dari BPJS kesehatan di pertengahan tahun. Kebijakan BPJS kesh ini terkait target pasien PRB sebanyak 3500 pasien
- d. Pencapaian nilai rata-rata *bed occupancy rate* (BOR) di tahun 2025 adalah 75,8%, sudah cukup bagus untuk ukuran RS swasta.
- e. Pencapaian nilai *average lenght of stay* (ALOS) dari tahun ke tahun terjadi kenaikan, pada tahun 2019 (3,3 hari), tahun 2020 (2,5 hari), pada tahun 2021 sebesar 4 hari, pada tahun 2022 sebesar 3,7 ,pada tahun 2023 sebesar 3,6, pada tahun 2024 sebesar 3,3, dan pada tahun 2025 sebesar 3,7 masih belum ideal jika menurut Kemenkes/standard 6 hari.
 Nilai ALOS pada periode tahun 2019-2021 belum ideal menurut Depkes RI (2005) yaitu 6-9 hari. Nilai ALOS berada di bawah angka ideal, dikarenakan pasien rawat inap rata-rata BPJS. Dimana sistem BPJS adalah sistem paket dengan lama rawatan pada sistem paket BPJS adalah tidak terbatas. agar tidak mendapatkan kerugian di aspek ekonominya, rumah sakit akan mempersingkat lama rawatan pasien dengan catatan pasien sembuh atau langsung dirujuk. Begitu pula banyak pasien umum yang PAPS dengan alasan kekurangan biaya.
- f. Pencapaian nilai *turn over interval* (TOI) pada tahun 2019 8,25 hari , tahun 2020 sebesar 11,3 hari ,tahun 2021 sebesar 4,75 hari tahun 2022 sebesar 1,0 hari, tahun 2023 sebesar 0,8 hari, tahun 2024 sebebsar 0,8 dna tahun 2025 sebesar 0,9 hari masih terlalu Panjang jika dibandingkan dengan standard Kemenkes sebesar 1 - 3 hari.
 Pencapaian nilai TOI setiap tahun berada di atas angka ideal atau **belum ideal** yang telah ditetapkan terutama pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan semakin lama saat tempat tidur menunggu pasien.
- g. Pencapaian Nilai, *bed turn over* (BTO) pada tahun 2019 sebesar , tahun 2020 sebesar 25,5, tahun 2021 sebesar 64,5, tahun 2022 sebesar 97,7, tahun 2023 sebesar 108,25, tahun 2024 sebesar 118,3, dan tahun 2025 sebesar 104,5 **belum ideal**, belum sesuai standard Kemenkes 30-40 kali/tahun. Angka ini menunjukkan nilai BTO jauh di bawah angka ideal menurut Depkes RI (2005) yaitu 40-50 kali/tahun,.
- h. Pencapaian angka *gross death rate* (GDR) sebesar 26,7 ‰ di tahun 2025, nilai tersebut **sudah ideal**, sesuai standard (Kemenkes 2005) <45 ‰. Artinya angka kematian umum 1000 penderita keluar rumah sakit adalah 28 ‰ dan menunjukkan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit sudah cukup baik
- i. Pencapaian angka *net death rate* (NDR) pada tahun 2019 (4,2‰), tahun 2020 (9,9‰) **sudah ideal** namun pada tahun 2021 (9.9 ‰) meningkat cukup tinggi **belum ideal**, tahun 2022 mencapai 13,3‰, tahun 2023 mencapai 9,6‰, tahun 2024 mencapai 4,5‰, dan tahun 2025 mencapai 5,7‰ sudah sesuai standard kemenkes yaitu <25 ‰. Nilai NDR tersebut termaksud angka ideal menurut Depkes RI (2005) yaitu $\leq 25 \text{ ‰}$,

Dibawah ini Grafik Kinerja Produktifitas Rumah Sakit (Berbentuk Grafik) tahun 2019 sd 2025.









2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan (Analisis SWOT / TWOS)

Berdasarkan isu – isu yang berkembang di masyarakat dan pengamatan terhadap lingkungan strategis, dapat diidentifikasi kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman).

Identifikasi atas keempat aspek positif dan negatif organisasi tersebut akan membantu Rumah Sakit Prima Husada dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang akan diambil dalam pencapaian Misi dan Visi organisasi.

Analisis lingkungan internal Rumah Sakit Prima Husada memperhatikan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan dan analisis lingkungan eksternal memperhatikan unsur-unsur peluang dan ancaman sebagai berikut :

2.4.1. Kekuatan

- 1) Dukungan penuh pemilik rumah sakit.
- 2) Program pengembangan berkelanjutan.
- 3) Letak rumah sakit yang strategis sehingga mudah dijangkau dan dikelilingi oleh banyak perusahaan
- 4) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit semakin meningkat
- 5) Jumlah SDM dokter spesialis lengkap dan sudah mencukupi walaupun slot jam praktek masih ada perlu ditambah. Jumlah tenaga keperawatan dan tenaga lainnya relatif cukup
- 6) Rumah Sakit telah terakreditasi paripurna.
- 7) Rumah Sakit telah bekerjasama dengan BPJS dan asuransi lain
- 8) Sistem keuangan berjalan baik khususnya tahun 2021
- 9) Likuiditas dan solvabilitas baik
- 10) Bad debt rendah
- 11) Kinerja keuangan baik
- 12) Pola tarif yang bersaing dan tersedianya pola tarif dengan paket
- 13) Keunggulan pelayanan khusus di Rumah Sakit

2.4.2.Kelemahan

- 1) SDM rumah sakit belum mempunyai komitmen terhadap pelayanan yang bermutu tinggi termasuk money masih kurang
- 2) Kinerja SDM rumah sakit kurang optimal
- 3) Turn Over karyawan yang tinggi menyebabkan turunnya mutu pelayanan
- 4) Kurangnya Diklat teknis dan Non teknis untuk tenaga kesehatan
- 5) Kurangnya, loyalitas, etos kerja, budaya dan kepedulian karyawan kepada RSPH yang dapat mengakibatkan menurunnya tingkat pelayanan Rumah Sakit Prima Husada.
- 6) Kurangnya Profesionalisme SDM di RS
- 7) Fungsi organisasi kurang berjalan baik masih dalam perkembangan
- 8) Peralatan medik canggih masih kurang
- 9) Sistem informasi rumah sakit belum terpadu & belum lengkap (SIMRS)
- 10) Sumber pembayaran pasien BPJS masih kecil (50%) sehingga pendapatan juga belum optimal
- 11) Realisasi anggaran belum sepenuhnya mengacu pada alokasi anggaran (RBA-DPA)
- 12) Kecepatan Pembayaran Mitra kerja (BPJS, jaminan lain) belum sesuai target
- 13) Tarif rekanan rumah sakit relatif tinggi
- 14) Tarif harga jual obat masih cukup tinggi
- 15) Kualitas proses pelayanan pada pelanggan belum baik
- 16) Belum dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan optimal

2.4.3 Peluang

- 1) Kesempatan untuk meraih pasar konsumen menengah keatas dengan meningkatkan kerjasama dengan penjamin khususnya perusahaan BUMN, swasta dan BPJS.
- 2) Kesempatan untuk melakukan pemeriksaan calon jamaah haji.
- 3) Pengembangan Pelayanan Unggulan seperti Rehabilitasi Medis, Kulit-Cosmetik, Yankestrad, Truma center khususnya Ortopedi, MCU yang profesional
- 4) Pengembangan Pelayanan RS Kelas standard
- 5) Terbukanya kesempatan untuk KSO peralatan medik dan non medik
- 6) Kemajuan teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja RS
- 7) Kerjasama dengan pemasok dapat meringankan beban keuangan rumah sakit/PKS
- 8) Adanya komitmen dalam mendapatkan barang investasi dari Pemilik rumah sakit
- 9) Kemampuan bayar pasien yang cukup tinggi terbukti pasien umum cukup tinggi
- 10) Pengembangan kerjasama Kewajiban asuransi tenaga kerja di perusahaan (JKK)
- 11) Pemukiman penduduk yang cukup padat & perusahaan besar di sekitar rumah sakit merupakan pasar potensial untuk rumah sakit
- 12) Pemetaan FKTP yang bisa melakukan rujukan ke RSPH sesuai Zonasi

2.4.4 Ancaman

- 1) Bertambahnya jumlah Rumah Sakit baru merupakan pesaing yang perlu diwaspadai karena akan mengurangi Zonasi RSPH
- 2) Berlakunya kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).
- 3) Meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat akan meningkatkan potensi terjadinya complain sampai dengan tuntutan hukum.
- 4) Perkembangan Layanan Telemedicine
- 5) Ketidakpuasan dokter spesialis terhadap kebijakan manajemen RSPH

- 6) Kinerja rumah sakit belum optimal sehingga belum dapat memberikan insentif yang memadai untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan terutama profesi langka/terbatas
- 7) Masih ada beberapa fasilitas pelayanan kurang lengkap menyebabkan dilakukannya rujukan ke rumah sakit lain
- 8) Pembuangan Limbah/IPAL belum terstandar dengan baik sehingga memungkinkan untuk teguran dari Dinas terkait atau komplain masyarakat sekitar karena jika terlambat menguras akan berbau
- 9) Penetapan tarif lebih didasarkan pada kompetitor daripada unit cost
- 10) Master tarif untuk tarip BPJS belum ada menyebabkan tampak kerugian
- 11) Pendapatan insidental masa Pandemi Covid 19

2.5 Potensi dan Permasalahan

2.5.1. Geografis

Letak Rumah Sakit Prima Husada sangat strategis dan mudah terjangkau, yaitu di sebelah barat pintu masuk Taman Safari Indonesia, tepi jalan raya Provinsi. Perkembangan Kabupaten Pasuruan sebagai kota Industri terkait keberadaan PEAR di kecamatan Rembang yang jaraknya hanya ditempuh dalam waktu 30 menit dari RSPH dan letak RSPH disekitar banyak perusahaan. Selain itu Pasuruan juga merupakan kota wisata, yang merupakan potensi untuk kesempatan meraih pasar konsumen menengah ke atas. Letak Rumah Sakit Prima Husada yang strategis berpeluang mendapatkan kunjungan wisatawan, sehingga persiapan sebagai rumah sakit yang tanggap dalam pelayanan, menjadi pertimbangan. Namun dengan sistem zona untuk BPJS area yang sulit dijangkau adalah Kecamatan Tosari karena sangat jauh lokasinya merupakan wilayah terpencil diatas gunung Bromo.

2.5.2. Pelayanan

Beberapa hal yang harus diwaspadai bagi institusi penyedia pelayanan kesehatan adalah:

1. Meningkatnya usia harapan hidup menimbulkan semakin banyak ditemukan penyakit geriatri, degeneratif, kardiovaskuler, dan onkologi.
2. Pada era *baby boom* ini akan semakin banyak ditemukan penyakit pada ibu, anak, dan dewasa muda.
3. Lingkungan hidup yang kurang mendukung sehingga mempermudah timbulnya berbagai penyakit infeksi.
4. Mobilitas masyarakat yang mudah menyebabkan meningkatnya kasus traumatologi dan penyebaran infeksi, dan perubahan pola hidup menimbulkan penyakit kardiovaskuler.
5. Perubahan gaya hidup masyarakat saat ini mengakibatkan banyaknya penyakit metabolik.

2.5.3. Alat Kedokteran dan Kesehatan yang tersedia

Peralatan penunjang medik yang tersedia alat-alat kedokteran antara lain dapat dilihat **di Lampiran 1**

2.5.4. Pembiayaan

Kondisi keuangan Rumah Sakit dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan baik umum, BPJS ataupun Jaminan lain. Peningkatan yang signifikan adalah penjaminan biaya dari BPJS Kesehatan.

2.5.5. Kondisi Sosial Budaya

Faktor sosial budaya yang dapat mempengaruhi kegiatan rumah sakit antara lain adalah sikap dan perilaku masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit. Semua issue negative ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, budaya, status sosial ekonomi, dan kebiasaan masyarakat. Rumah Sakit harus menyiapkan pelayanan dengan berbagai faktor sosial budaya serta siap memilih menggunakan strategi yang terkait dengan Sosial dan Budaya.

2.5.6. Pesaing Rumah Sakit

Di kawasan Kabupaten Pasuruan terdapat 6 rumah sakit swasta dan 2 RS negeri dari berbagai kelas. Terdapat 5 RS Swasta kelas D dan 1 RSUD kelas B dan 1 RSUD kelas C serta 1 RS Swasta kelas C dari mereka semua sudah melaksanakan akreditasi minimal 4 standard utama. Pesaing pasti telah siap memperbaiki pelayanan menjadi lebih baik, sehingga mau tidak mau mereka adalah pesaing bagi Rumah Sakit Prima Husada. Untuk menghadapi pesaing, manajemen rumah sakit perlu memperhatikan pangsa pasar yang dibidik, efektifitas pelayanan, kompetisi biaya, kapasitas produksi, posisi keuangan, mutu pelayanan, kualitas SDM, dan citra Rumah Sakit. Untuk merebut pangsa pasar, Rumah Sakit Prima Husada berusaha mengungguli pesaingnya melalui perbaikan mutu pelayanan, kualitas SDM yang terus menerus melalui berbagai macam diklat, workshop dan peningkatan SDM yang lainnya. Pemberian pelayanan yang berfokus pada Pasien centered care dan berfokus pada keselamatan pasien dengan menyajikan mutu layanan yang lebih baik, serta tarif pelayanan yang lebih terjangkau. Yang tidak kalah penting adalah mengupayakan untuk mengubah pesaing menjadi mitra kerja. Banyaknya rumah sakit swasta menjadikan persaingan merebut pasien kelas menengah keatas menjadi lebih berat. Namun RS Prima Husada Sukorejo adalah satu-satunya RS Swasta dengan kelas C yang mempunyai kelebihan dalam bangunan Fisik yang mewah. Untuk itu perlu strategi pemasaran yang tepat sesuai pangsa pasar agar semakin banyak pasien menengah keatas yang mau berobat ke Rumah Sakit Prima Husada.

2.5.7. Pemasaran

Pangsa pasar yang cukup kuat adalah Peserta BPJS yang kian hari kian meningkat yang bisa ditargetkan sd 85% dari semua pengunjung RSPHS. Walaupun saat ini peserta BPJS mengikuti system Zona sesuai kesepakatan dan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Dinkes dan BPJS dimana RSPH Sukorejo mendapatkan rujukan hanya dari yang berasal dari 9 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Sukorejo
2. Kecamatan Pandaan
3. Kecamatan Prigen
4. Kecamatan Purwosari
5. Kecamatan Purwodadi
6. kecamatan Tutar dan Nongkojajar
7. Kecamatan Wonorejo
8. Kecamatan Kejayan
9. Kecamatan Tosari

Peserta Umum masih merupakan pasar nomor 2 setelah BPJS yang bisa mengalihkan pangsa pasar Pasuruan yang selama ini berobat ke RS swasta di Surabaya. Asuransi Lain dan juga perusahaan melalui program kerjasama di bidang pelayanan kesehatan selama ini menempati peringkat

pasar ke3. Kegiatan pemasaran atau sosialisasi rumah sakit juga dilakukan melalui:

1. Corporate Gathering
2. Pembinaan Komunitas berbasis RSPHS
3. Kemitraan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti
 - a. Muslimat,
 - b. Fatayat,
 - c. IPP-IBNU NU,
 - d. Hympaudi,
 - e. IGRA
 - f. IGTKI
 - g. PITRA
 - h. PKHI
 - i. IBI
 - j. IDI
 - k. PPNI

Kerjasama kemitraan dengan Lembaga atau organisasi lain, baik yang tingkat Kecamatan, tingkat kabupaten maupun Provinsi Jawa Timur. Kegiatan KIE kesehatan masyarakat, melalui berbagai media social, upaya peningkatan mutu maupun peningkatan citra Rumah Sakit melalui berbagai kegiatan, dimaksudkan menunjang pemasaran Rumah Sakit. Memberikan kepuasan pasien dalam mendapatkan pelayanan medis merupakan salah satu cara untuk promosi melalui pasien dan keluarganya.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Isu- isu strategis yang berkembang di lingkungan internal dan eksternal RS Prima Husada Sukorejo menjadi perhatian penting dalam penyusunan rencana strategis. Adapun isu-isu penting tersebut adalah :

A. Permasalahan Internal

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dimungkinkan terjadi di RS Prima Husada Sukorejo, digunakan alat bantu *Balance Score Card (BSC)* yang meliputi :

a. Perspektif Keuangan (*Financial*).

- 1) Belum tercapainya target pendapatan RS Prima Husada Sukorejo
- 2) Efisiensi biaya operasional yang masih rendah
- 3) Rendahnya kuota layanan.
- 4) Kurang optimalnya tingkat keuntungan RS dibandingkan dengan jumlah pegawai (*Earning per employe*).

Maka strateginya adalah Peningkatan pendapatan rumah sakit disertai langkah efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

b. Perspektif Pelanggan (*Customer*)

Keluhan pelanggan masih cukup banyak seperti :

- 1) Rendahnya jumlah pasien baru
- 2) Penurunan kepuasan pasien
- 3) Rendahnya kampanye untuk layanan unggulan rumah sakit
- 4) Adanya retensi pasien lama karena adanya kebijakan eksternal
- 5) Pelayanan yang kurang cepat, tepat dan akurat di semua layanan

c. Perspektif Bisnis Internal:

- 1) Kualitas pelayanan IGD masih kurang untuk menjadikan RS Prima Husada Sukorejo Trauma senter,
- 2) Kualitas atau mutu pelayanan IRNA, IRJA, IKO, pendaftaran dan Rekam Medis Gizi, Radiologi, laborat, IFRS, (semua unit) masih kurang
- 3). Pelayanan medis belum dilakukan secara cost effective
- 4) Masih belum terpenuhinya kebutuhan Ruangan untuk pengembangan pelayanan ;R.HCU , dan R. PICU
- 5) R.IGD, IKO, PONEK, Maternitas belum terintegrasi
- 6) Masih banyak kekurangan peralatan yang seharusnya menjadi standard di unit
- 7) Tingginya Insiden keselamatan pasien
- 8) ERM masih belum menyeluru
- 9) Belum memaksimalkan manfaat pelayanan asuransi lain diluar BPJS

d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (*Learn and Growth*)

- 1) Belum ada manajemen zero komplek.
- 2) Belum terpenuhinya kebutuhan SDM berkualitas serta memiliki budaya mengutamakan mutu dan keselamatan pasien dengan memperhatikan penilaian kinerja dan jenjang karier
- 3) Skill dan kompetensi SDM masih kurang atau belum sesuai standard
- 4) Jumlah SDM spesialis atau home dokter masih kurang
- 5) Tim di pelayanan masih dalam taraf membangun Tim (*Team building*),
- 6) Indeks kepuasan karyawan masih rendah

- 7) Budaya kerja dan Budaya keselamatan pasien yang terbangun belum optimal
 - 8) Belum ada pola untuk mengatasi *Turn Over Staf* yang masih tinggi
 - 9) Capaian diklat TNA yang masih rendah
- B. Beberapa permasalahan eksternal yang saat ini terjadi antara lain :
- a. Kebijakan BPJS yang berubah ubah dan semakin ketat
 - b. Kebijakan terkait rumah sakit berdasarkan kompetensi
 - c. Tuntutan Standard Mutu Nasional dari Pemerintah
 - d. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih cepat, tepat, akurat
 - e. Akreditasi RS sesuai kebijakan Pemerintah
 - f. Tuntutan kepuasan pelanggan
 - g. Kondisi sosial ekonomi dan budaya di Kabupaten Pasuruan yang unik dan spiritual

3.2. Telaah Renstra Kementerian RI /Lembaga (K/L)

Renstra Kemenkes RI sebagai acuan bagi Rumah Sakit yang ada di Indonesia. Sesuai dengan Renstra Kemenkes, dimana arah dan kebijakan strategis terkait dengan RS dititik beratkan pada :

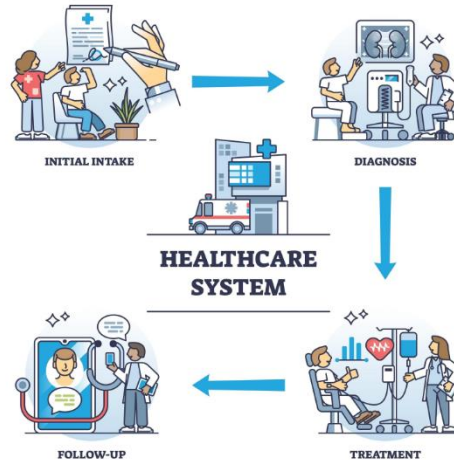
- a. Pelayanan RS PONEK di seluruh provinsi, kabupaten/ kota dalam rangka menekan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta meningkatkan Umur Harapan Hidup.
- a Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan pemberian Jaminan Kesehatan berupa perlindungan kesehatan kepada setiap orang dengan iuran yang telah dibayarkan oleh pemerintah (*Universal Coverage*).

3.3. Penentuan Isu – Isu Strategis

1. Perubahan Regulasi dan Sistem Pembiayaan
 - a. Kelas Rawat Inap Standart (KRIS)
Kewajiban menyesuaikan fasilitas fisik sesuai 12 kriteria KRIS yang akan mengubah kapasitas dan manajemen ruang rawat inap
 - b. Transisi Sistem Klaim
Adanya perubahan sistem INA-CGGs ke IDRG serta tantangan dalam mengelola klaim pending. Data menunjukkan klaim pending Rawat Inap (RITL) masih cukup tinggi (10,2%)
 - c. Ketergantungan BPJS
Ketergantungan BPJS dengan 77,8% pendapatan berasal dari BPJS, RS sangat rentan terhadap kebijakan rujukan berbasis kompetensi dan tuntutan efisiensi biaya (*cost – effective*)
2. Peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien
 - a. Pelayanan sesuai PNKP/ PPK
Masalah yang diidentifikasi meliputi penulisan resume medis yang belum lengkap, diagnose IGD yang kurang akurat, serta Clinical Pathway (CP) yang belum terintegrasi sepenuhnya dengan sistem elektronik (E-RM).
 - b. Audit Klinis
Perlunya megaktifkan komite medik dalam melakukan audit kepatuhan DPJP terhadap standart pelayanan untuk mencegah dispute klaim dan memastikan keselamatan pasien.
3. Transformasi budaya dan pengalaman pasien (*Zero complaint*)
RS Prima Husada Sukorejo menargetkan perubahan budaya organisasi untuk meningkatkan daya saing:
 - a. Masalah etika pelayanan (*attitude*)
Keluhan pasien tertinggi berkaitan dengan sikap staf. Strategi kedepan focus pada pelatihan empati dan *Service Excellence*.

b. Bottleneck pelayanan

Waktu tunggu farmasi yang bisa mencapai 3 jam dan proses pindah kamar dari IGD ke Rawat inap yang lambat menjadi isu kritis yang harus diselesaikan melalui digitalisasi antrian



Gambar 1. Alur pelayanan

4. Efisiensi operasional dan penguatan tata Kelola

Untuk menjaga keberlangsungan bisnis, RS fokus pada optimalisasi sumber daya:

- Manajemen SDM: Tantangan tingkat *turnover* karyawan (9,3%) dan perlunya sistem penggajian berbasis kompetensi, bukan sekadar masa kerja.
- Digitalisasi (SIMRS & E-RM): Integrasi sistem secara menyeluruh untuk mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) dan mempercepat alur pelayanan medis serta administrasi klaim.
- Optimalisasi Aset: Evaluasi terhadap alat medis dengan utilitas rendah (seperti C-Arm) dan pengadaan sarana yang menunjang layanan unggulan baru untuk memperluas pangsa pasar.

BAB IV

VISI, MISI, LANDASAN NILAI, DAN TUJUAN

5.1. Visi

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.
Tujuan dari Visi ini masih belum bisa dilaksanakan 100% karena permasalahan SDM, pelayanan masih kurang.

5.2. Misi

1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat, dan akurat.
2. Mengutamakan kepuasan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

Kejadian ketidak patuhan terhadap regulasi masih banyak ditemukan apalagi komplain pasien dan keluarga pasien dapat dilihat pada hasil kuesioner selama 3 tahun (lampiran 2), sedangkan program mutu RS baru saja berjalan lagi setelah hampir 2 tahun tidak aktif.

5.3. Falsafah

Memberikan pelayanan secara professional berlandaskan hati nurani dengan selalau berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.

5.4. Landasan Nilai

Nilai 7 Budi Utama:

1. Jujur
2. Tanggung jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

5.5. Tujuan

Untuk mewujudkan visi, misi Rumah Sakit Prima Husada.

5.6. Motto

Sahabat Menuju Sehat

Masih ditemukan masalah terkait dengan sikap atau attitude SDM yang tidak bersahabat atau tidak ramah kepada pelanggan.

BAB V
POSISI BISNIS

5.1. Swot Analisis

a. Penentuan rating atau skala

No	Kondisi	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
1	Sangat	4	-4	4	-4
2	Normal	3	-3	3	-3
3	Agak	2	-2	2	-2
4	Sedikit	1	-1	1	-1

Cara Baca : Jika kondisi sangat berpeluang, maka ratingnya bernilai 4

b. Penentuan Bobot

Bobot diberikan per kategori/masalah, total bobot dalam satu bagian (S/W/O/T) harus bernilai 1 (satu).

Semakin penting suatu kategori/masalah maka bobot yang diberikan makin besar.

b Penentuan Skor

Skor merupakan hasil perkalian antara rating dan bobot
Jumlahkan skor yang terhimpun dalam factor internal dan factor eksternal
Skor akhir dalam factor internal dan eksternal akan menjadi data yang disajikan dalam diagram kartesius

PEMBOBOTAN

1.	SDM dan Manajemen	35%	4
2.	Sarana & Prasarana	25%	3
3.	Keuangan	20%	2
4.	Pemasaran	20%	1
	Jumlah	100%	

5.1.1 KEKUATAN

No.	FAKTOR	BOBOT FAKTOR (%)	BOBOT SUB FAKTOR (%)	RATING	NILAI
A	KEKUATAN				
1.	SDM DAN MANAJEMEN	35%			
a.	Dukungan penuh oleh pemilik terhadap manajemen RS		35%	4	0,49
b.	Program pengembangan berkelanjutan		30%	4	0,42
c.	Tersedianya Jumlah SDM yang cukup		20%	3	0,21
d.	Adanya SIMRS yang bisa menunjang keputusan manajemen		15%	3	0,16
No	Faktor	Bobot faktor	Bobot Sub faktor	Rating	Nilai
	Jumlah (1)		100%		1,28
2.	SARANA DAN PRASARANA	25%			
a.	Lokasi rumah sakit yang strategis		35%	4	0,35
b.	Bangunan rumah sakit megah dengan fasilitas yang cukup lengkap		30%	4	0,30
c.	Tersedianya peralatan medik yang cukup		15%	4	0,15
d.	Tersedianya ruang perawatan yang memenuhi kehendak pasar		20%	4	0,20
	Jumlah (2)		100%		1,00
3.	KEUANGAN	20%			
a.	Sistem keuangan berjalan baik		30%	4	0,24
b.	Likuiditas dan solvabilitas baik		30%	4	0,24
c.	Bad debt rendah		20%	4	0,16
d.	Kinerja keuangan baik		20%	3	0,12
	Jumlah (3)		100%		0,76
4.	PEMASARAN	20%			
a.	Pola tarif yang bersaing		45%	4	0,36
b.	Tersedianya pola tarif dengan paket		35%	3	0,21
d.	Keunggulan pelayanan khusus di Rumah Sakit		20%	4	0,16
	Jumlah (4)		100%		0,73
	TOTAL KEKUATAN	100%			3,77

5.1.2 KELEMAHAN

No.	FAKTOR	BOBOT FAKTOR (%)	BOBOT SUB FAKTOR (%)	RATING	NILAI
-----	--------	--------------------	------------------------	--------	-------

B	KELEMAHAN				
1.	SDM DAN MANAJEMEN	35%			
a.	Kinerja SDM rumah sakit kurang optimal		25%	4	0,36
b.	SDM rumah sakit belum mempunyai komitmen terhadap pelayanan yang bermutu tinggi		30%	3	0,31
c.	Turn over yang cukup tinggi		30%	4	0,42
d.	Manajemen mutu dan SDM masih lemah		15%	3	0,16
	Jumlah (1)		100%		1,25
2.	SARANA DAN PRASARANA	25%			
a.	Peralatan medik canggih masih kurang		30%	4	0,30
b.	ERM masih belum menyeluruh		30%	4	0,30
c.	Sering terjadi peralatan canggih rusak		20%	3	0,15
d.	Fasilitas pelayanan masih kurang		20%	2	0,10
	Jumlah (2)		100%		0,85
3.	KEUANGAN	20%			
a.	Arus kas bergantung pada klaim BPJS kesehatan		40%	2	0,16
b.	Realisasi anggaran belum sepenuhnya mengacu pada alokasi anggaran (RBA-DPA)		25%	4	0,25
c.	Kecepatan Pembayaran Mitra kerja (BPJS, jaminan lain) belum sesuai target		35%	1	0,07
	Jumlah (3)		100%		0,48
4.	PEMASARAN	20%			
a.	Tarif rekanan rumah sakit relatif tinggi		40%	3	0,24
b.	Kualitas proses pelayanan pada pelanggan belum baik		40%	2	0,16
c.	Belum dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan optimal		20%	4	0,25
	Jumlah (4)		100%		0,55
	TOTAL KELEMAHAN	100%			-3,06

5.1.3 PELUANG

No.	FAKTOR	BOBOT FAKTOR (%)	BOBOT SUB FAKTOR (%)	RATING	NILAI
	PELUANG				

1.	SDM DAN MANAJEMEN	35%			
a.	Tersedianya SDM berbagai profesi yang dapat direkrut untuk peningkatan kinerja rumah sakit		20%	3	0,21
b.	Kebijakan dan komitmen Pemilik rumah sakit untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanan rumah sakit		40%	4	0,56
c.	Komitmen manajemen RS yang kuat		40%	4	0,56
	Jumlah (1)		100%		1,33
2.	SARANA DAN PRASARANA	25%			
a.	Terbukanya kesempatan untuk KSO peralatan medik dan non medik		30%	4	0,30
b.	Pemanfaatan digital health		30%	4	0,30
c.	Dengan semakin terbuka pasar, memudahkan rumah sakit dalam mendapatkan peralatan dengan harga yang lebih kompetitif		40%	4	0,40
	Jumlah (2)		100%		1,00
3.	KEUANGAN	20%			
a.	Kerjasama dengan pemasok dapat meringankan beban keuangan rumah sakit/PKS		20%	4	0,16
b.	Adanya komitmen dalam mendapatkan barang investasi dari Pemilik rumah sakit		40%	4	0,32
c.	Kemampuan bayar pasien yang cukup tinggi terbukti pasien umum cukup tinggi		40%	3	0,24
	Jumlah (3)		100%		0,72
4.	PEMASARAN	20%			
a.	Pengembangan kerjasama inhouse klinik di perusahaan		40%	4	0,32
b.	Pemukiman penduduk yang cukup padat & perusahaan besar di sekitar rumah sakit merupakan pasar potensial untuk rumah sakit		50%	4	0,40
c.	Pemetaan FKTP yang bisa		20%	4	0,16

	melakukan rujukan ke RSPH sesuai Zonasi				
	Jumlah (4)		100%		0,88
	TOTAL PELUANG	100%			3,93

5.1.4 ANCAMAN

D	ANCAMAN				
1	SDM DAN MANAJEMEN	35%			
a.	Adanya ketidakpuasan staf terhadap kebijakan manajemen rumah sakit		40%	-3	0,42
b.	Masih belum solidnya komitmen SDM yang berada di dalam rumah sakit		40%	-3	0,42
c.	Kinerja rumah sakit belum optimal sehingga belum dapat memberikan insentif yang memadai untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan terutama profesi yang langka/ terbatas		20%	-3	0,21
	Jumlah (1)		100%		1,05
	SARANA DAN PRASARANA	25%			
a.	Belum lengkapnya fasilitas pelayanan menyebabkan dilakukannya rujukan ke rumah sakit lain		40%	-4	0,40
b.	kelengkapan ruang pelayanan belum optimal		40%	-3	0,30
c.	Risiko bencana infrastruktur karena berada di jalur padat		20%	-3	0,15
	Jumlah (2)		100%		0,85
	KEUANGAN	20%			
a.	Ketergantungan tinggi pada klaim BPJS kesehatan		40%	-4	0,32
b.	Inflasi medis dan kenaikan harga BMHP		30%	-4	0,32
c.	Kenaikan biaya operasional karena kenaikan upah minimum		30%	-3	0,12
	Jumlah (3)		100%		0,76
	PEMASARAN	20%			
a.	Munculnya rumah sakit baru dan pengembangan rumah sakit lain merupakan kompetitor potensial		40%	-4	0,40

b.	Persaingan tarif dengan rumah sakit sekitar		35%	-2	0,14
c.	Kemasan pemasaran yang kurang inovatif dan frekwensi kurang dibanding RS lain terutama di Medsos		25%	-3	0,15
	Jumlah (4)		100%		0,69
	TOTAL ANCAMAN	100%			3,35

5.1 Hasil Analisa

5.2.1 Analisa Internal

No.	Bidang	Nilai	
		Kekuatan	Kelemahan
1.	SDM dan Organisasi	1,28	1,25
2.	Sarana dan Prasarana	1,00	0,85
3.	Keuangan	0,76	0,48
4.	Pemasaran	0,73	0,55
	Total	3,77	3,13

5.2.2 Analisa Eksternal

No.	Bidang	Nilai	
		Peluang	Ancaman
1.	SDM dan Organisasi	1,33	1,05
2.	Sarana dan Prasarana	1,00	0,85
3.	Keuangan	0,72	0,76
4.	Pemasaran	0,88	0,69
	Total	3,93	3,35

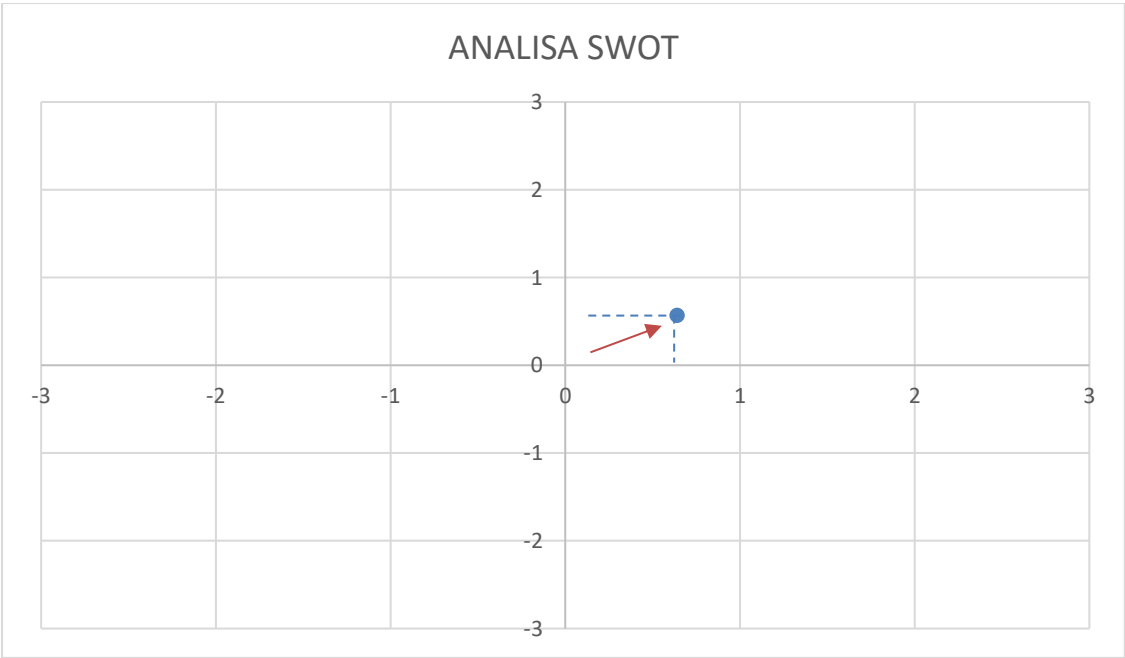
Berdasarkan analisis SWOT tersebut dapat ditentukan koordinat sebagai berikut

Sumbu X = kekuatan - kelemahan = 3,77-

3,13 = 0,64

Sumbu Y = peluang - ancaman = 3,93 -

3,36 = 0,57



Posisi RSPH Sukorejo dalam posisi kuadran 1 walaupun masih sangat kecil namun akan dapat berkembang dengan pesat.

BAB VI

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

6.1 Kebijakan

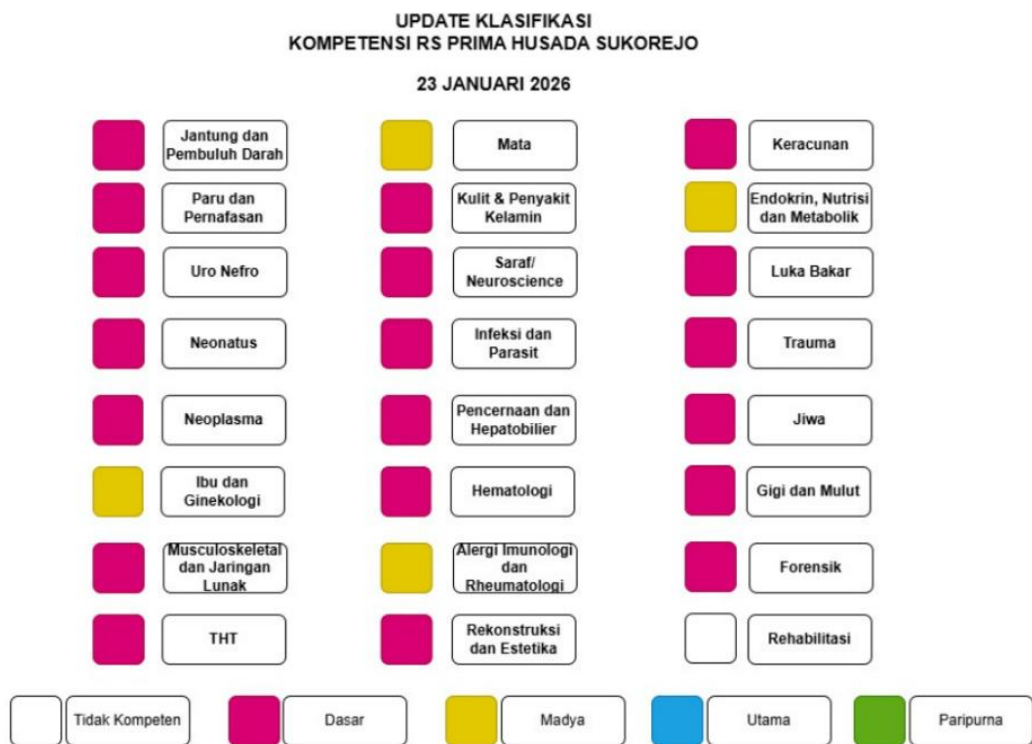
Kebijakan umum pelayanan di RSPH Sukorejo sebagai rumah sakit Swasta Tahun 2026 – 2030 adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan operasional berbasis efisiensi.
 - a Optimalisasi inventaris dengan menerapkan sistem kontrol stok obat dan bahan medis habis pakai untuk menghindari pemborosan dan kadaluarsa
 - b Efisiensi energi dan umum dengan mengurangi biaya operasional non medis melalui penghematan energi dan digitalisasi administrasi (paperless)
- 2) Kebijakan peningkatan kepuasan pelanggan melalui fokus pelanggan.
- 3) Kebijakan pengendalian biaya dan penatausahaan keuangan untuk meningkatkan dan memperbaiki pengelolaan keuangan.
- 4) Kebijakan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu pada semua lapisan masyarakat.
- 5) Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana layanan yang berkualitas.
- 6) Kebijakan rumah sakit berdasarkan kompetensi

6.2. Strategi

Strategi pengembangan pelayanan RSPH Sukorejo Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut.

- 1) Strategi Peningkatan Kualitas pelayanan melalui pencapaian Akreditasi yang paripurna. Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan adalah dengan indikator Standar Pelayanan sesuai Regulasi & Akreditasi yang dikelompokkan dalam 4 (empat) perspektif dengan metoda **Balanced Score Card (BSC)**, yaitu:
 - a. Perspektif Keuangan : masalah : pendapatan masih belum sesuai target.
 - b. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran : penerapan semua strategi yang bisa menumbuhkan kualitas pelayanan dan sebagai ajang pembelajaran bagi masyarakat RSPH dengan pelaksanaan penilaian atau audit dari dalam dan dari luar melalui visitasi pemerintahan dan Lembaga akreditasi
 - c. Perspektif Proses **Bisnis Internal** : mutu layanan masih kurang
 - d. Perspektif Pelanggan (**Customer**) : kepuasan pelanggan masih belum optimal
- 2) Strategi Pengembangan Pelayanan dilaksanakan melalui 4 perspektif, sebagai berikut.
 - a. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
 - b. Perspektif Proses **Bisnis Internal**
 - c. Perspektif Pelanggan (**Customer**)
 - d. Perspektif Keuangan
- 3) Strategi peningkatan kompetensi rumah sakit dari dasar menuju madya pada 24 kompetensi



Gambar 2. Capaian klasifikasi kompetensi RS Prima Husada Sukorejo

Berdasarkan data geografis yang terletak berdekatan dengan perusahaan serta berada di jalur utama jalan provinsi maka Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo memiliki layanan unggulan sebagai rumah sakit trauma center. Pada tahun 2026 RS Prima Husada Sukorejo akan mengembangkan peningkatan kompetensi dari dasar menuju madya pada jenis kompetensi Rehabilitasi medik, trauma, muskuloskeletal, rekonstruksi dan estetika serta kulit dan kelamin. Untuk menunjang Rumah sakit Prima Husada menjadi rumah sakit trauma center maka pada tahun 2027 RS Prima Husada Sukorejo akan mengembangkan POTS (Pelayanan orthopedi Trauma Center)

- 4) Strategi pemeliharaan aktiva C-Arm
- Aktiva yang masih belum berjalan dengan aktif di RS Prima Husada Sukorejo adalah penggunaan C-Arm. Pada Tahun 2025 penggunaan C-Arm hanya dilakukan sebanyak 14 kasus dan digunakan hanya pada kasus orthopedi. Pada tahun kedepan diperlukan pemaksimalan penggunaan C-Arm pada kasus bedah, urologi, Orthopedi dan bedah syaraf, selain itu juga diperlukan marketing ke rumah sakit lain.
- 5) Strategi pemeliharaan aktiva C-Arm bus MCU
- Bus MCU belum menjadi profit center dan masih menjadi cost center pasif. Produktivitas yang rendah ini diperlukan keaktifan penggunaan bus MCU melalui MCU onsite.
- 6) Strategi Klaim Paripurna
- Strategi klaim paripurna dilakukan dengan menempatkan anggota verifikator rawat inap di Irna lantai 2 dan lantai 3. Tupoksi staf tersebut adalah melakukan pengecekan dokumentasi klinis PPA sesuai dengan PNPK, PPK/CP dan BA kesepakatan. Strategi lain adalah dengan adanya dokter casemix yang berfungsi sebagai narahubung komunikasi antara verif dengan DPJP.
- 7) Strategi Zero Komplen

Adanya penurunan kepuasan pasien pada tahun 2025 dari semester 1 sebanyak 95% menjadi 91 % pada semester 2 menunjukkan banyak masih adanya pasien yang tidak puas dengan pelayanan yang sudah diberikan. Ketidakpuasan pasien sebanyak 70% disebabkan karena masalah etika dan komunikasi untuk itu diperlukan pelatihan customer service dan menjalankan pemilihan staf untuk menjadi tim patient experience di unit IGD dan farmasi.

8) Strategi pelayanan medis sesuai PNPK

Pembuatan PPK/ CP yang dilakukan pada 10 diagnosa terbanyak adalah strategi untuk meningkatkan Clinical Documentation Improvement. Pembuatan PPK didasari pada PNPK, A kesepakatan dan KMKB.

BAB VII
RENCANA BISNIS STRATEGIS (RBS) DAN TARGET RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TAHUN 2026-2030

	Strategi Peningkatan Kualitas pelayanan melalui pencapaian Akreditasi							
A	Perspektif keuangan							
NO	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	STANDAR	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Peningkatan pendapatan rumah sakit disertai langkah efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.	Cost Recovery Rate (CRR)	>100%	100%	100%	105%	110%	120%
		Rata-rata pertumbuhan pendapatan (SGR)	15% dari tahun lalu	10 %	15%	15 %	15 %	15 %
		Meningkatkan pendapatan pelayanan untuk segmen diluar pasien BPJS.	25% dari total pasien	15%	20 %	25 %	25 %	25%
		Meningkatkan pendapatan pelayanan medis untuk pasien BPJS.	60% dari total pasien	50%	55%	60%	60%	60 %
		Meningkatkan pendapatan pelayanan MCU dan penunjang medis lain	10 %	7 %	9 %	10 %	10 %	10 %
		Meningkatkan pendapatan RSPH diluar pelayanan medis. (Koperasi, Sewa lahan, Parkir, kantin, toko, dan yang lain)	5% dari pendapatan medis	2 %	3%	5 %	5 %	5%
B.	Perspektif Proses Bisnis Internal							
1	Meningkatkan mutu layanan di Kamar operasi (OK)	a. Kejadian infeksi pasca operasi	< 1, 5%	<1,5%	<1,5%	<1,5%	<1,5%	<1,5%
		b. Kejadian Infeksi Nosokomial	< 1, 5%	<1,5%	<1,5%	<1,5%	<1,5%	<1,5%
		c. Perbedaan Dx Pre dan Post	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		d. Kejadian Tidak dilakukannya Proses monitoring pemulihan anestesi	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		e. kejadian tidak dilaksanakannya pengisian Surgical safety checklist sesuai standar	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Meningkatkan mutu layanan Rawat inap	a. Kematian pasien >48 jam	< 25 per mil	20	15	10	10	10
		b. (NDR)						
		c. Keterlambatan visite dokter	< 1 jam dari	< 1 jam	< 1 jam	< 1 jam	< 1 jam	< 1 jam

	(IRNA)	Spesialis lebih dari 1 jam	jam visite					
		d. Kematian pasien < 48 jam (	< 45 per mil	44	60	50	40	40
		e. GDR						
		f. BOR	75 – 85%	25	50%	75%	80	85%
		g. BTO	5 – 45 hr	60	58	55	50	45
		h. TOI	1 – 3 hr	3	3	2	2	2
		i. Pasien pulang paksa	<5%	4%	3%	2%	1%	1%
4	Meningkatkan mutu layanan Maternitas	a. Ketidakmampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	Meningkatkan mutu layanan farmasi	a. Ketidakpatuhan penulisan resep sesuai formularium	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		b. Angka ketidaklengkapan penulisan Resep	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Meningkatkan mutu layanan Laboratorium	a. Waktu lapor nilai kritis laboratorium	< 30 menit	< 30'	< 30'	< 30'	< 30'	< 30'
		b. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Respon Time < 1 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Meningkatkan mutu layanan Gizi	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	< 20%	10%	5%	0%	0%	0%
8	Meningkatkan mutu layanan Rekam Medik	Kelengkapan pengisian rekam medik assesmen awal medis sesuai akreditasi <=24 jam setelah selesai pelayanan rawat inap dan kembali ke Rekam Medik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kejadian Nomor RM ganda	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9	Meningkatkan mutu layanan IRJA	Waktu tunggu Rawat jalan Dari TTV sampai layanan DPJP	< 2 jam	< 2 jam	< 2 jam	< 2 jam	< 2 jam	< 2 jam
		Ketidak lengkapan pengisin Form PRMRJ	0%	0%	0%	0%	0%	0%

10	Meningkatkan mutu layanan Rekam medik	Ketidak lengkapan Dokumen RM pasien KRS	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Tulisan Dokter tidak terbaca	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11	Meningkatkan mutu layanan IGD	Kematian Pasien Kurang dari 24 Jam	< 2 permil	< 2 permil	< 2 permil	< 2 permil	< 2 permil	< 2 permil
		Waktu tanggap pelayanan P1 0 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Waktu tanggap pelayanan P2 < 5 meni	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Waktu tanggap pelayanan P3 < 30 mnit		100%	100%	100%	100%	100%
		Resptime dalam pemberian layanan balasan perujuk melalui WA	< 5 menit	< 5 menit	< 5 menit	< 5 menit	< 5 menit	< 5 mnit
11	Meningkatkan mutu Keselamatan Pasien	a. Ketidakpatuhan dalam Identifikasi Pasien	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		b.Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan/kematian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Ketidak patuhan petugas dalam pengisian SBAR saat konsultasi DPJP	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12	Peningkatan pengendalian dan pencegahan Infeksi	a. Ketidak patuhan cuci tangan	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%
		b. Ketidak Patuhan Penggunaan APD	0%	0%	0%	0%	0%	0%

C. Perspektif Pelanggan (Customer)

	Meningkatkan kepuasan Customer	a.Persentase jumlah penduduk yang memanfaatkan RSPH 9 Kecamatan sesuai Zona RSPH	5-10 %	5 %	7 %	9 %	10 %	10 %
		b.Kepuasan Pelanggan Rawat inap	> 90 %	80 %	90 %	90 %	90 %	90 %

		c. Kepuasan Pelanggan Rawat Jalan	> 90 %	80 %	90 %	90 %	100 %	100 %
		d. Kepuasan Pelanggan IGD	> 90 %	80 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		e. kepuasan Pelanggan MCU	> 90 %	80 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		f. kepuasan Pelanggan untuk layanan lain-lain	> 90%	80 %	90 %	90 %	90 %	90 %
D. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran								
1	Pemenuhan kebutuhan SDM berkualitas serta memiliki budaya mengutamakan mutu dan keselamatan pasien dengan memperhatikan penilaian kinerja dan jenjang karir	Memenuhi kebutuhan diklat sesuai dengan TNA (Training Need Analysis).	100%	50%	75%	100%	100%	100%
		a Perawat dari D3 ke S1	100%	50%	50%	75 %	100%	100%
		b TTK ke S1	100%	50%	75%	100%	100%	100%
		c Gizi S1	100%	50%	75%	100%	100%	100%
		d 15 Bab dalam akreditasi	100%	75%	100%	100%	100%	100%
		e SPI, KFT, HTA	100%	75%	100%	100%	100%	100%
		f HD, NICU	100%	50%	100%	100%	100%	100%
		g Mata, Jantung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		h Budaya Kerja	100%	50%	75 %	100%	100 %	100%
		i Karakter Building sesuai 7 nilai budi utama	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pemenuhan kebutuhan SDM sesuai Kompetensi dan kualifikasi	a Semua penempatan Staf sesuai Kompetensi dan kualifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. Strategi Pengembangan Pelayanan

Strategi pengembangan pelayanan dilaksanakan melalui 4 perspektif (BSC), sebagai berikut:

a. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

NO	STRATEGI	TARGET				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Rekrutmen tenaga profesional (dokter spesialis, tenaga ahli , tenaga lainnya)	V	V	V	V	V
2	Simulasi Akreditasi Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit	V				
3	Penilaian akreditasi Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit	V				V
4	Pembiayaan Pendidikan pelatihan SDM Khusus untuk Unit khusus	V	V	V	V	V
5	Pengiriman Diklat /seminar dan workshop SDM eksternal	V	V	V	V	V
6	Meningkatkan manajemen PDSA mutu dalam memberi pelayanan	V	V	V	V	V
7	Peningkatan Monev atau supervisi berjenjang	V	V	V	V	V
8	Pendayagunaan SPI sebagai Satuan Pengawas Internal RS					
9	Penyediaan Kelas extension Pendidikan Perawat D3 ke S1 di RSPHS (IKS dengan Stikes/Universitas)	V	V	V	V	V

b. Perspektif Proses Bisnis Internal

NO	STRATEGI	TARGET				
		2026	2027	2028	2029	2030
1.	Operasional dan peningkatan pelayanan IGD, ICU Rawat Jalan. Rawat Inap, Penunjang medis-non medis	V	V	V	V	V
2.	Operasional + peningkatan Penata usahaaan manajemen marketing-Pemasaran	V	V	V	V	V
3.	Mengembangkan kerjasama dengan BPJS	V	V	V	V	V
4.	Mengembangkan kerjasama dengan asuransi swasta & perusahaan	V				
5.	Mengembangkan pelayanan HCU			V		
6.	Mengembangkan POTS (Prima Orthopedi and Trauma Services)		V			

7.	Pengembangan Pelayanan menu makanan di GIZI sesuai kebutuhan pelanggan RS	V	V	V	V	V
8.	Mengembangkan pelayanan Hemodialisa	V			V	
9.	Pembangunan Gedung 5 lantai, untuk poli, rawat inap dan POTS	V	V			
10.	Pengoperasionalan Gedung 5 lantai, untuk poli, rawat inap dan POTS			V	V	
11.	Pengembangan Cathlab				V	
11	E-Rekam medis Terintegrasi dengan satu sehat	V				
12	Penambahan layanan Rehab medik untuk Terapi Wicara (Tumbuh Kembang)		V			
13	Penambahan layanan Rehab medik untuk Terapi Okupasi		V			
14	Pembangunan gedung WorkShop IPS dan gudang		V			
15	Pengoperasionalan/pemanfaatan R.Work Shop IPS		V			
16	Pengoprasionalan Studio Rekaman PKRS	V				
NO	STRATEGI	TARGET				
		2026	2027	2028	2029	2030
c	Perspektif Pelanggan (Customer)					
1	Meningkatkan loyalitas pelanggan melalui program Patient Experience	V	V	V	V	V
2	Meluaskan sasaran promosi pelayanan kesehatan di internal dan eksternal RS dengan sasaran: a. Corporate Gathering, b. Media social (IG, FB, Website) c. Secara langsung ke perusahaan , d. Pemberdayaan masyarakat, e. Pembinaan komunitas berbasis RSPH. f. Promkes tidak langsung melalui media elektronik , media Cetak, siaran radio, Lomba ,pemberdayaan pasien dan keluarga serta pelanggan dll	V	V	V	V	V
3	Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan <i>service excellent</i>	V	V	V	V	V
4	Meluaskan sasaran promosi melalui pengadaan kegiatan keagamaan di Musholla RSPH (pembinaan Komunitas berbasis RS)	V	V	V	V	V

d. Perspektif Keuangan						
NO	STRATEGI	TARGET				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Penetapan target pendapatan pada tiap unit pelayanan	V	V	V	V	V
2	Implementasi INACBG's menggunakan <i>clinical pathway</i>	V	V	V	V	V
3	Peningkatan pendapatan melalui sewa lahan, gedung, kantin, fasilitas penunjang yang lain	V	V	V	V	V
4	Peningkatan pendapatan melalui parkir	V	V	V	V	V
5	Peningkatan pendapatan melalui pembukaan ATM	V	V	V	V	V

BAB VIII
PROYEKSI KEUANGAN RS PRIMA HUSADA SUKOREJO TAHUN 2026 - 2030

8.1 Data Pendapatan 2025

Pendapatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Total 2025
Umum	1022.082.377	975.034.549	980.228.829	898.614.284	911.851.815	914.966.456	856.387.530	991.057.500	894.609.362	996.077.117	1.182.617.967	1.060.421.129	11.683.948.915
Asuransi	390.111.873	542.761.667	298.045.749	338.553.169	418.580.697	394.829.853	529.827.550	521.697.172	487.690.815	433.171.794	386.864.710	449.653.950	5.191.788.999
Perusahaan	215.199.011	199.900.760	203.184.539	184.177.572	297.295.803	235.000.269	370.686.205	214.980.455	339.884.734	284.474.657	246.200.708	217.889.939	3.008.874.652
BPJS Kes	8.361.969.497	8.962.673.258	10.719.149.612	9.622.025.778	9.416.443.412	10.705.894.918	12.312.587.276	13.557.505.587	10.913.268.500	8.812.286.329	9.158.6363.252	12.554.778.221	125.097.218.640
Jasa Raharja	343.841.420	350.634.951	533.959.234	502.580.916	363.544.689	425.017.908	667.733.263	381.404.927	398.672.826	240.936.999	347.330.627	246.830.912	4.802.488.732
BPJS Ketenagakerjaan	237.571.107	572.505.937	928.016.607	443.594.476	620.962.873	530.053.822	705.806.261	617.612.029	738.547.528	404.269.115	493.478.531	330.320.603	6.622.738.889
Lain2 (MCU, Parkir, inhouse Klinik, dan Kantin)	305.377.779	277.323.077	273.503.189	281.494.373	263.454.371	339.068.356	278.297.203	330.108.686	273.483.943	265.920.214	252.823.370	302.878.783	3.443.733.474
Total	10.876.153.064	11.880.834.329	13.936.087.759	12.271.040.568	12.292.133.660	13.544.831.642	15.721.325.288	16.614.366.356	14.046.157.708	11.437.136.225	12.067.952.165	15.162.773.537	159.850.792.301

8.3 PROYEKSI

Tabel 8.3.1 Rincian Pendapatan

Indikator	2026 Proyeksi	2027 Proyeksi	2028 Proyeksi	2029 Proyeksi	2030 Proyeksi
Asuransi	7.154.659.741,73	9.032.757.923,94	9.123.085.503,18	9.214.316.358,21	9.306.459.521,79
BPJS Kes	112.685.890.932,32	108.393.095.087,28	109.477.026.038,15	110.571.796.298,53	111.677.514.261,52
BPJS TK	12.520.654.548,04	14.452.412.678,30	14.596.936.805,09	14.742.906.173,14	14.890.335.234,87
JR	8.943.324.677,17	10.839.309.508,73	10.947.702.603,81	11.057.179.629,85	11.167.751.426,15
Perusahaan	5.365.994.806,30	7.226.206.339,15	7.298.468.402,54	7.371.453.086,57	7.445.167.617,43
Umum	17.886.649.354,34	12.645.861.093,52	12.772.319.704,45	12.900.042.901,50	13.029.043.330,51
Lain - Lain	14.309.319.483,47	18.065.515.847,88	18.246.171.006,36	18.428.632.716,42	18.612.919.043,59
Total	178.866.493.543,36	180.655.158.478,79	182.461.710.063,58	184.286.327.164,22	186.129.190.435,86
Pendapatan / Bulan	14.905.541.128,61	15.054.596.539,90	15.205.142.505,30	15.357.193.930,35	15.510.765.869,66

BAB IX

PENUTUP

Renstra Rumah Sakit Prima Husada 2026-2030 merupakan program utama kegiatan Rumah Sakit Prima Husada tahun 2026-2030. Sehingga Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan semua satuan kerja dilingkungan Rumah Sakit Prima Husada dalam pembuatan program kerja.

Usaha dan partisipasi semua satuan kerja telah diikutsertakan dalam usaha menyusun renstra ini. Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk terdapatnya kekurangan didalamnya. Kerjasama dan partisipasi aktif dari seluruh komponen dalam melaksanakan Renstra ini diharapkan mampu membawa Rumah Sakit Prima Husada mencapai sasaran yang ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan,
Pada tanggal 24 Januari 2026
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Heni Indra Wulansari.,S.Kep.,Ns., M.Kep